AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Microbiología

25 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Urgencias Críticas, Sepsis e Infecciones del SNC

★☆☆ 1.1. Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora) GES 3
★★☆ 1.2. Meningitis Aguda Bacteriana y Viral GES 4
★★☆ 1.3. Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral GES 5
★☆☆ 1.4. Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig GES 6

02 Salud Pública, Profilaxis Post-Exposición e IAAS

★☆☆ 2.1. Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes GES 7
★☆☆ 2.2. Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico GES 8
★★★ 2.3. IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento 9
★☆☆ 2.4. Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera 10

03 Infecciones Crónicas, Retrovirales y Granulomatosas

★★★ 3.1. Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES) GES 11
★★★ 3.2. Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA GES 12
★★★ 3.3. Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR 13
★★☆ 3.4. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas GES 14
★★★ 3.5. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH GES 15

04 Zoonosis, Medicina Tropical y Vectores

★☆☆ 4.1. Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH) 16
★★★ 4.2. Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica 17
★☆☆ 4.3. Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla 18
★★☆ 4.4. Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis 19
★★☆ 4.5. Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea 20
★☆☆ 4.6. Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio) 21

05 Infecciones Comunitarias, Exantemas y Huésped Inmunocomprometido

★★★ 5.1. Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis 22
★★★ 5.2. Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH GES 23
★★★ 5.3. Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki 24
★★☆ 5.4. Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster 25
★★☆ 5.5. Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco GES 26
★★☆ 5.6. Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño) 27

Números que tienes que saber 28
Fármacos de primera línea 31
GES de la especialidad 33
Plan de repaso de 7 días 35
Índice por prioridad ★ 36

BLOQUE 01 · URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

Máxima rentabilidad · aparece en el 100% de las versiones del EUNACOM

1.04.2.007 **Sepsis y shock séptico** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Septicemia · Shock · Hemocultivo · Alteración de la termoregulación

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El concepto de SIRS fue eliminado**: Sepsis = sospecha de infección + disfunción orgánica aguda (SOFA **≥ 2**).
- **qSOFA (≥ 2 de 3)**: FR **≥ 22 rpm**, Glasgow < 15, Presión Sistólica **≤ 100 mmHg**. Herramienta de alarma rápida.
- **Shock Séptico** = necesidad de vasopresores para PAM **≥ 65 mmHg** a pesar de **30 mL/kg** de fluidos Y Lactato > 2 mmol/L.
- **Vasopresor de 1ª línea indiscutido**: Noradrenalina EV. La dopamina está en desuso por arritmias y mayor mortalidad.
- **Paquete 1ª hora**: Lactato + Hemocultivos x 2 + ATB amplio espectro EV + Cristaloides **30 mL/kg** + Noradrenalina precoz.

ALGORITMO · SEPSIS: DE LA SOSPECHA AL VASOPRESOR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

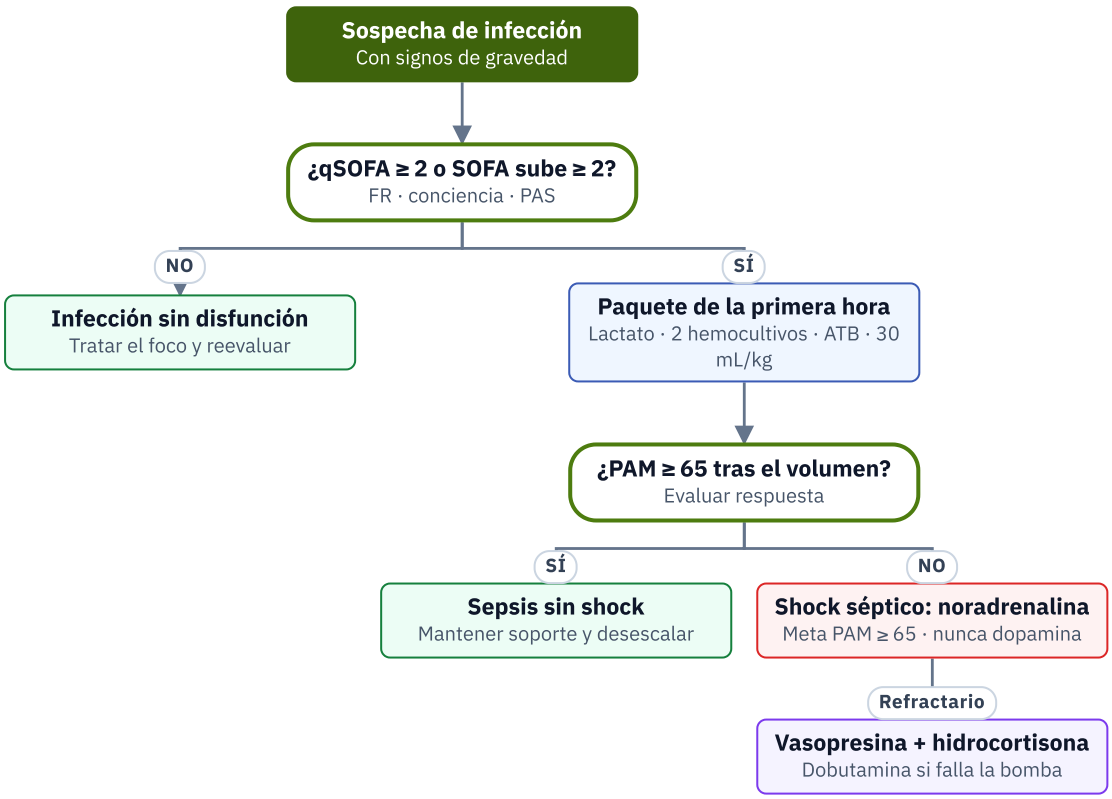


TABLA 1.1 · SEPSIS VS SHOCK SÉPTICO VS HIPOVOLEMIA — DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PARÁMETRO	SEPSIS (SEPSIS-3)	SHOCK SÉPTICO	HIPOTENSIÓN HIPOVOLÉMICA
Criterio clínico	Infección + aumento SOFA ≥ 2	PAM < 65 post-fluidos + Lactato > 2	Déficit intravascular puro
Respuesta a 30 mL/kg	Estabiliza PA transitoriamente	Refractario; persiste hipotensión	Restaura PA y perfusión 100%
Vasopresor de elección	No indicado (solo fluidos)	Noradrenalina (meta PAM ≥ 65)	Contraindicado (requiere volumen)
Lactato Sérico	Normal o leve elevación	> 2 mmol/L post-fluidos	Normal o normaliza con volumen
Mortalidad	10% a 15%	> 40%	< 5% con reposición

REGLA DE ORO **Sepsis = infección + SOFA ≥ 2** — El SIRS se abandonó

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **4–5** (pág. 8) · solucionario pág. 21.

Clase 1.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

Máxima rentabilidad · diagnóstico diferencial de LCR y banderas rojas de TAC

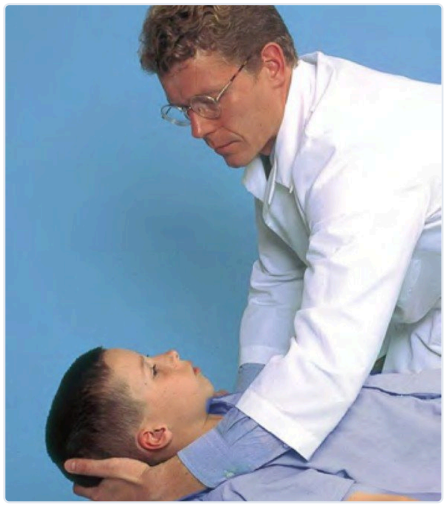
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.04.2.006 **Meningitis aguda** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Estudio citoquímico de LCR · Punción lumbar · Meningitis bacteriana · Meningococcemia · Sembrar muestras para cultivo · Síndromes meníngeos con meningitis purulenta o bacteriana

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Tríada meníngea**: fiebre + rigidez de nuca + alteración mental. La ausencia de los 3 descarta prácticamente el cuadro.
- **Citoquímico bacteriano**: PMN > **80 %**, proteínas > **100 mg/dL** y consumo severo de glucosa (ratio LCR/suero < 0.4).
- **Citoquímico viral**: predominio mononuclear/linfocítico con GLUCOSA NORMAL y proteínas levemente aumentadas.
- **Banderas rojas para TAC previo a PL**: focalidad neurológica, convulsión nueva, Glasgow < 10, papiledema e inmunodepresión.
- **Si requiere TAC**: administrar Dexametasona + ATB EV de inmediato antes del traslado, NUNCA demorarlos.
- **En > 50 años, alcohólicos y embarazadas**: agregar siempre AMPICILINA para cubrir Listeria monocytogenes.



RIGIDEZ DE NUCA
Bates 12.ª ed., Fig. 18-72

ALGORITMO · MENINGITIS AGUDA: TAC, TRATAMIENTO Y LCR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

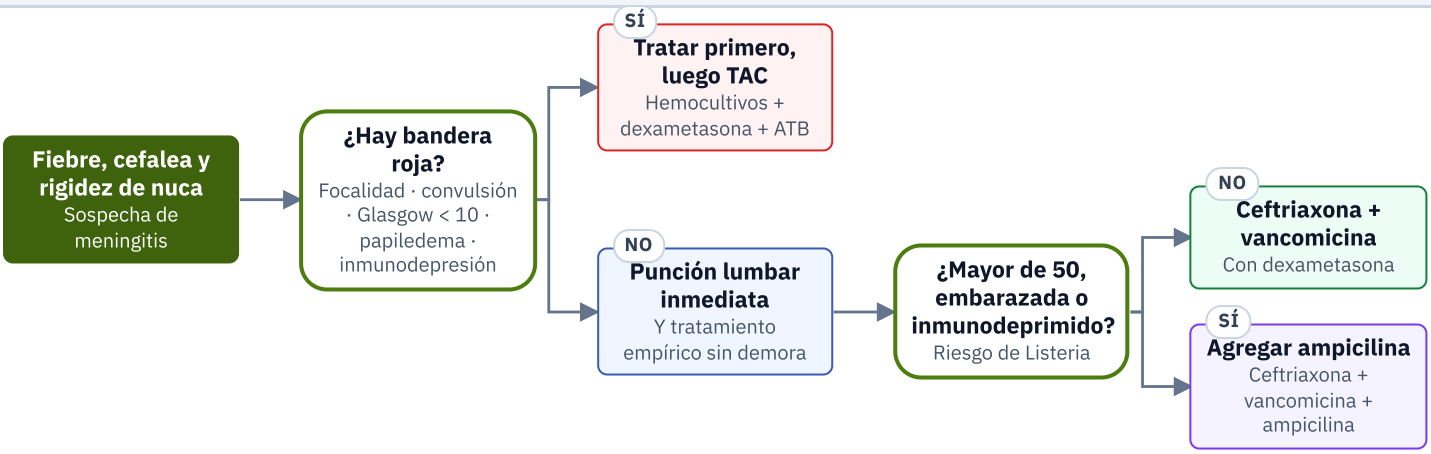


TABLA 1.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL CITOQUÍMICO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

PARÁMETRO	NORMAL	BACTERIANA AGUDA	VIRAL (ASÉPTICA)	TUBERCULOSA / FÚNGICA
Presión apertura	10–20 cm H2O	Elevada (> 25 cm H2O)	Normal o leve aumento	Marcadamente elevada (> 30)
Leucocitos /mm³	< 5	Muy alto (1.000–10.000+)	Moderado (50–500)	Moderado (100–500)
Predominio celular	Mononucleares	Polimorfonucleares (> 80%)	Mononucleares / Linfocitos	Mononucleares / Linfocitos
Glucosa (LCR/Suero)	> 0.6 (> 60%)	Baja (< 0.4 / < 40 mg/dL)	Normal (> 0.6)	Muy baja (< 0.3)
Proteínas	< 45 mg/dL	Muy elevadas (> 100–500)	Leve aumento (50–100)	Muy elevadas (100–500+)

REGLA DE ORO **Focalidad, convulsión, Glasgow < 10** — Papiledema o inmunodepresión: TAC primero

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **6–9** (págs. 8–9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

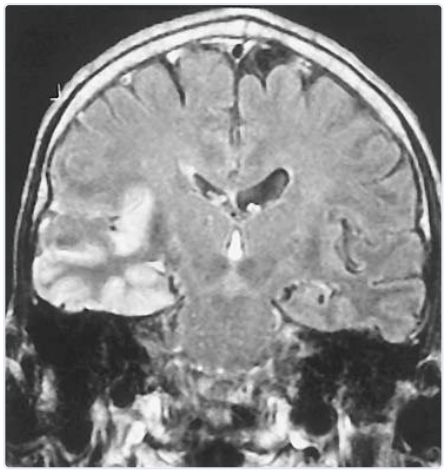
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
7 preguntas reales 2013–2025

1.04.2.002 Encefalitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome encefalítico (Herpes Simplex) · Absceso cerebral · Meningoencefalitis/ Meningitis bacteriana aguda

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Encefalitis** = fiebre + alteración de funciones cerebrales superiores (afasia, delirio, conducta bizarra, crisis focales).
- **Causa más frecuente y letal**: Virus Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1), con tropismo temporal y frontal basal.
- **Examen de imagen más sensible**: Resonancia Magnética (hiperintensidad temporal asimétrica en secuencias FLAIR).
- **Test de confirmación**: PCR para VHS en líquido cefalorraquídeo.
- **Tratamiento de elección inmediato**: Aciclovir **10 mg/kg** cada **8 horas** EV por **14 a 21 días**.
- **En absceso cerebral de origen ótico o sinusal**: la combinación empírica es Ceftriaxona + Metronidazol (para anaerobios).



ENCEFALITIS HERPÉTICA
Harrison 21.ª ed., p. 1137

ALGORITMO · FIEBRE CON COMPROMISO NEUROLÓGICO

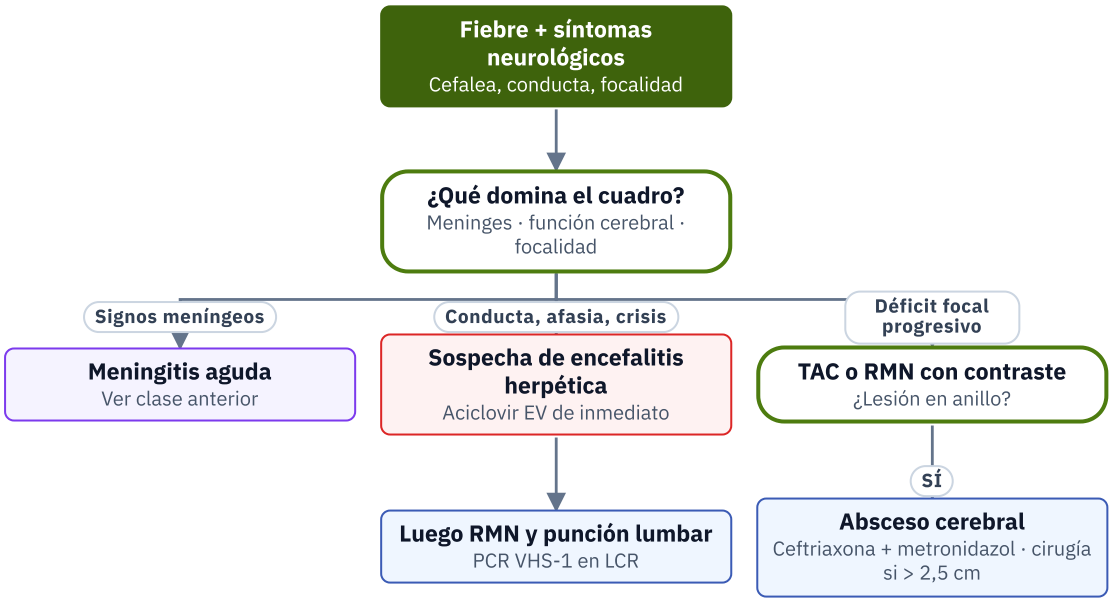


TABLA 1.3 · MENINGITIS VS ENCEFALITIS VS ABSCESO CEREBRAL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CARACTERÍSTICA	MENINGITIS AGUDA	ENCEFALITIS HERPÉTICA	ABSCESO CEREBRAL
Compromiso cerebral	Ausente (conciencia clara o somnolencia)	Marcado (afasia, conducta bizarra, crisis)	Focalidad motora o sensitiva progresiva
Signos meníngeos	Marcados (rigidez, Kernig, Brudzinski)	Ausentes o leves	Raros (salvo rotura intraventricular)
Hallazgo en Imagen	Habitualmente normal (realce meníngeo)	Hiperintensidad temporal en RMN (FLAIR)	Lesión con captación en anillo y edema
LCR patognomónico	Bacteriana: PMN + glucosa baja	Linfocitos + hematíes / PCR VHS (+)	PL contraindicada por riesgo de herniación
Tratamiento de elección	Ceftriaxona + Vancomicina (± Ampicilina)	Aciclovir 10 mg/kg c/8h EV por 14-21 d	Ceftriaxona + Metronidazol + Cirugía

REGLA DE ORO **Fiebre + función cerebral alterada** — Conducta, afasia, crisis focales

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **10–13** (pág. 9) · solucionario pág. 22.

Clase 1.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.04.2.005 Infección invasiva de partes blandas: celulitis, fasceitis, miositis necrotizantes o septicémicas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Flegmón submaxilar, submandibular y del piso de la boca · Adenitis, adenoflegmón · Fasceitis necrotizante

LO QUE TE PREGUNTAN

- El signo de sospecha más precoz de fascitis necrotizante es el DOLOR DESPROPORCIONADO al aspecto externo de la piel.
- **Signos duros que confirman necrosis**: flictenas serohemáticas, crepitación (gas tisular), anestesia cutánea focal y toxicidad sistémica.
- La exploración quirúrgica en pabellón con desbridamiento de urgencia es la medida terapéutica que define la sobrevida.
- NUNCA solicitar resonancia o TAC para confirmar la sospecha si ello demora la entrada a pabellón quirúrgico.
- **Antibioticoterapia de elección**: Meropenem + Vancomicina + Clindamicina (la clindamicina bloquea la síntesis de toxinas pirogénicas).
- **Angina de Ludwig**: celulitis bilateral submandibular/sublingual de origen dental; prioridad número 1 es asegurar la vía aérea.



GANGRENA DE FOURNIER
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · INFECCIÓN DE PARTES BLANDAS: SIMPLE, NECROTIZANTE O VÍA AÉREA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

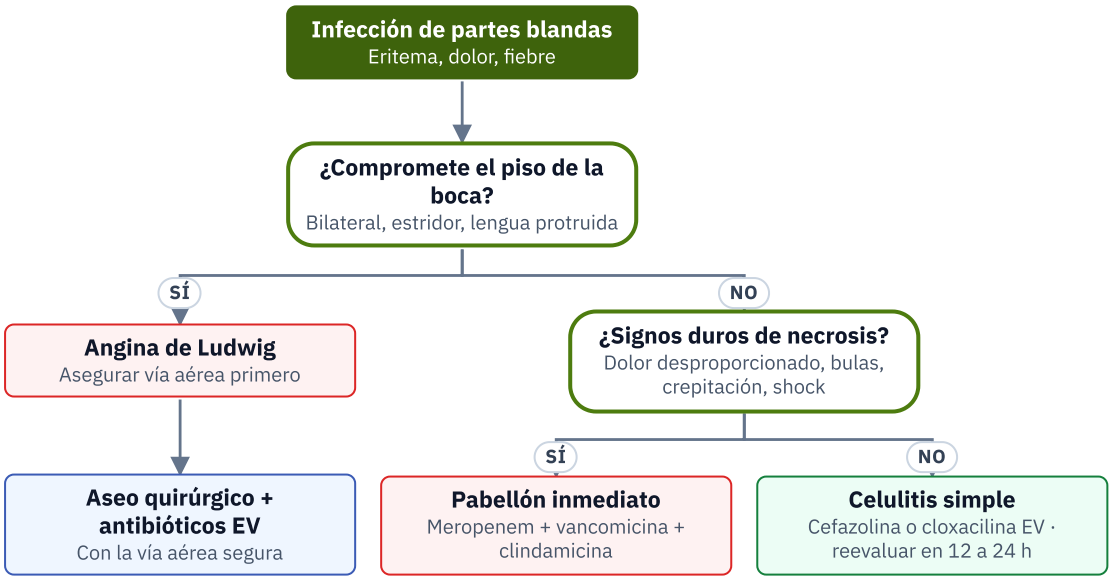


TABLA 1.4 · CELULITIS SIMPLE VS INFECCIÓN NECROTIZANTE DE PARTES BLANDAS

CARACTERÍSTICA	CELULITIS / ERISIPELA	FASCITIS NECROTIZANTE
Dolor y clínica	Proporcional al eritema visible	Severo, lacerante y desproporcionado al examen
Signos locales críticos	Calor, rubor y edema con fóvea	Flictenas hemorrágicas, crepitación, anestesia focal
Compromiso sistémico	Fiebre moderada, hemodinamia estable	Shock séptico, lactato elevado, falla multiorgánica
Conducta de elección	Antibióticos orales o EV en sala	Pabellón urgente + desbridamiento amplio + clindamicina

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	CELULITIS O ERISIPELA	FASCITIS NECROTIZANTE
Antibiótico	Cefazolina o cloxacilina EV	Meropenem + vancomicina + clindamicina

REGLA DE ORO — **Dolor desproporcionado** — El signo más precoz

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **14–18, 73** (págs. 9–10, 18) · solucionario págs. 22–23, 31.

Clase 1.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

Alta rentabilidad · preguntas estructuradas sobre profilaxis de TBC en niños, accidente cortopunzante laboral y meningitis

1.04.3.009 **Profilaxis de tuberculosis** — Conocimiento general

También: Profilaxis en contactos de infecciones meningocócicas · Manejo y prevención de infecciones en personal sanitario · PPD · Punción venosa

LO QUE TE PREGUNTAN

- Todo menor de **15 años** contacto de TBC bacilífera recibe isoniazida de entrada, sin importar el PPD inicial.
- El PPD solo se indica de rutina en menores de **15 años** y pacientes VIH; en adultos sanos no se pide de rutina.
- **Duración de profilaxis TBC**: adultos PPD > **10 mm** = **6 meses**; VIH PPD > **5 mm** = **9 meses**; menor de **15 años** = **6 meses** si vira o **3 meses** si persiste PPD (-).
- **RN de madre con TBC**: isoniazida **6 meses**, diferir BCG, mantener lactancia materna con mascarilla.
- **Profilaxis de contactos de meningitis**: SOLO se realiza para Meningococo (Rifampicina **2 días** o Cipro/Ceftriaxona dosis única) y Haemophilus influenzae b (Rifampicina **4 días**).
- En embarazada contacto de meningococo, el antibiótico de elección es Ceftriaxona **250 mg** IM dosis única.
- **Coqueluche**: profilaxis con Azitromicina por **5 días** a contactos sintomáticos y a grupos de alto riesgo (< 1 año, embarazadas 3er trimestre).

ALGORITMO · EXPOSICIÓN A UN AGENTE TRANSMISIBLE: QUÉ PROFILAXIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 2.1 · REGLAS DE QUIMIOPROFILAXIS EN CONTACTOS EUNACOM

ESCENARIO DE CONTACTO	POBLACIÓN OBJETIVO	ESQUEMA PROFILÁCTICO	PERLA CRÍTICA DE EXAMEN
TBC Pulmonar (BK+)	Menores de 15 años convivientes	Isoniazida directa (3 meses si PPD -; 6 meses si vira)	Todo < 15 a recibe isoniazida aunque PPD inicial sea 0 mm
RN de madre con TBC	Hijo de madre con TBC activa	Isoniazida 6 meses + postergar BCG al final	Lactancia materna permitida con mascarilla materna
Meningitis meningocócica	Convivientes en últimos 7 días	Rifampicina 600 mg c/12h x 2 días (o Cipro dosis única)	En embarazadas usar Ceftriaxona 250 mg IM dosis única
Accidente cortopunzante	Punción laboral con fuente VIH(+) o desc.	Triterapia oral x 28 días iniciada antes de 72 h	Nunca demorar PEP esperando resultado serológico de la fuente

REGLA DE ORO **Primero descartar TBC activa** — Radiografía y baciloscopías

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **23–26** (pág. 11) · solucionario pág. 24.

Clase 2.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

2.2 Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

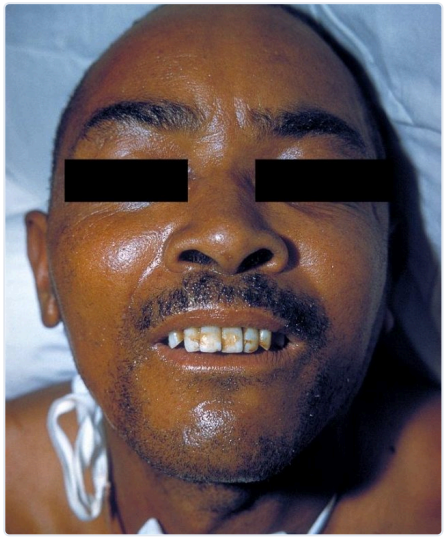
Alta rentabilidad · algoritmos estricto de mordeduras por perro/murciélago y vacuna antitetánica

1.04.2.009 Tétanos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Profilaxis de tétanos · Mordeduras de animales · Vacunas especiales (neumococo, influenza, hepatitis A y B, varicela, rabia, meningococo)

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Rabia por perro/gato ubicable**: observación por **10 días**. Si el animal está sano al día 10, NO se vacuna al paciente.
- **Rabia por murciélago**: contacto = exposición grave = VACUNA INMEDIATA + INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA en el **100%** de los casos.
- **Tétanos**: toxina bloquea la liberación de GABA y glicina en las interneuronas medulares inhibitorias.
- **Herida limpia**: refuerzo de toxoide si pasaron > **10 años**. Herida sucia: refuerzo si pasaron > **5 años**.
- **Inmunoglobulina antitetánica (IGH-T)**: SOLO se administra si la herida es sucia/tetanígena Y el esquema es desconocido o < 3 dosis.
- **Manejo de tétanos establecido**: Ingreso a UCI en box oscuro y silencioso, Metronidazol EV (o Penicilina), IGH-T **3.000-6.000 UI**, sedación y relajantes musculares.



RISA SARDÓNICA
CDC PHIL 2857, dominio público

ALGORITMO · PACIENTE CON UNA HERIDA: RABIA Y TÉTANOS

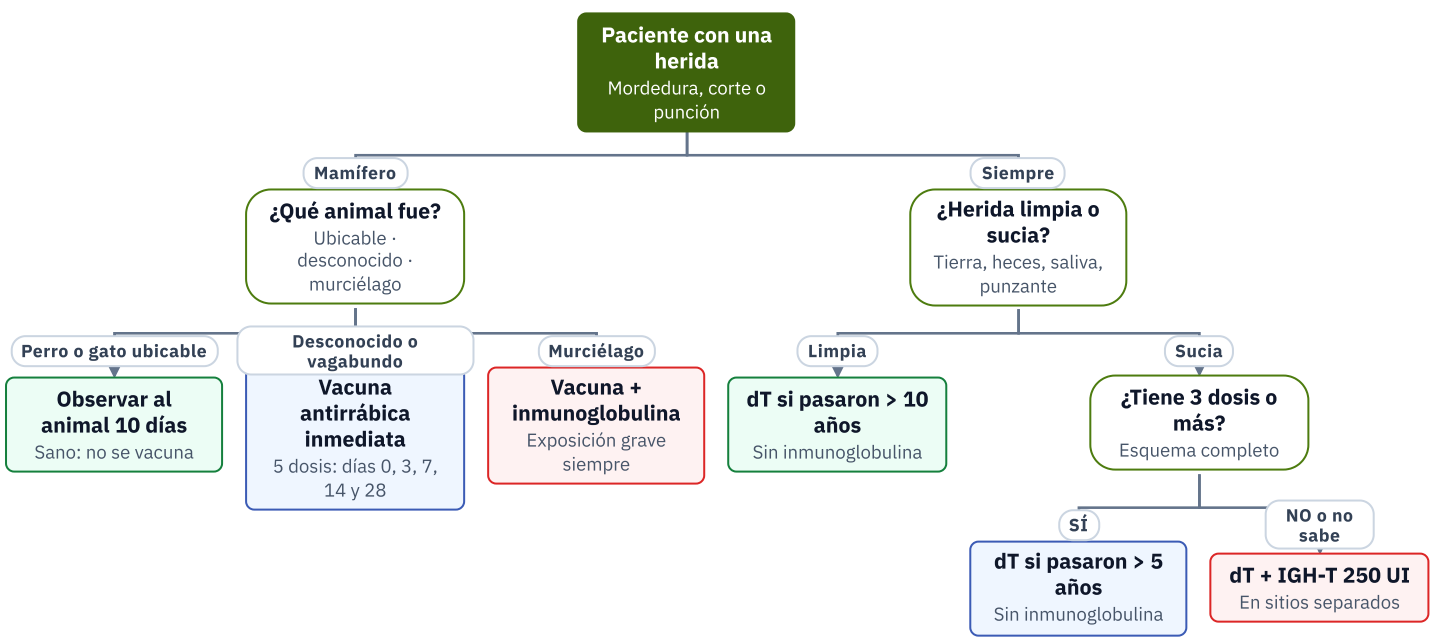


TABLA 2.2 · MATRIZ DE CONDUCTA OFICIAL EN PROFILAXIS ANTITETÁNICA (MINSAL)

HISTORIA DE VACUNACIÓN PREVIA	HERIDA LIMPIA Y SUPERFICIAL	HERIDA SUCIA / TETANÍGENA / PUNZANTE
Incompleta (< 3 dosis) o Desconocida	Vacuna (dT) 3 dosis · Sin IGH-T	Vacuna (dT) 3 dosis + Inmunoglobulina (IGH-T 250 UI)
Completa (≥ 3 dosis) · Última < 5 años	No requiere nada	No requiere nada
Completa (≥ 3 dosis) · Última 5 a 10 años	No requiere nada	Solo refuerzo de Vacuna (dT) · Sin IGH-T
Completa (≥ 3 dosis) · Última > 10 años	Solo refuerzo de Vacuna (dT)	Solo refuerzo de Vacuna (dT) · Sin IGH-T

REGLA DE ORO **Perro o gato ubicable: observar 10 días** — Si sigue sano, no se vacuna

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **27–29** (págs. 11–12) · solucionario págs. 24–25.

Clase 2.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.015 **Infecciones asociadas a catéteres vasculares** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Prevención de infecciones hospitalarias · Cateterismo venoso central · Uso y abuso de antibióticos · Instalación y cuidado de sonda Foley

LO QUE TE PREGUNTAN

- Clostridioides difficile requiere Aislamiento de Contacto y LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN (el alcohol no inactiva esporas).
- Tuberculosis activa, Sarampión y Varicela exigen Aislamiento AÉREO: mascarilla N95 y habitación con PRESIÓN NEGATIVA.
- Meningococo exige Aislamiento de GOTITAS (mascarilla quirúrgica) hasta cumplir **24 horas** de antibióticos efectivos.
- **Bacteriemia por catéter por Staphylococcus aureus o Candida**: el CVC se debe RETIRAR SIEMPRE sin excepción.
- **Diagnóstico de bacteriemia por CVC**: crecimiento del mismo germen en CVC y periférico con diferencia de positividad > **2 horas** a favor del CVC.
- **Criterios de retiro de CVC**: shock séptico, S. aureus, hongos (Candida), infección del trayecto tunelizado y bacteriemia persistente a las **72 h**.

ALGORITMO · FIEBRE EN PACIENTE CON CATÉTER VENOSO CENTRAL

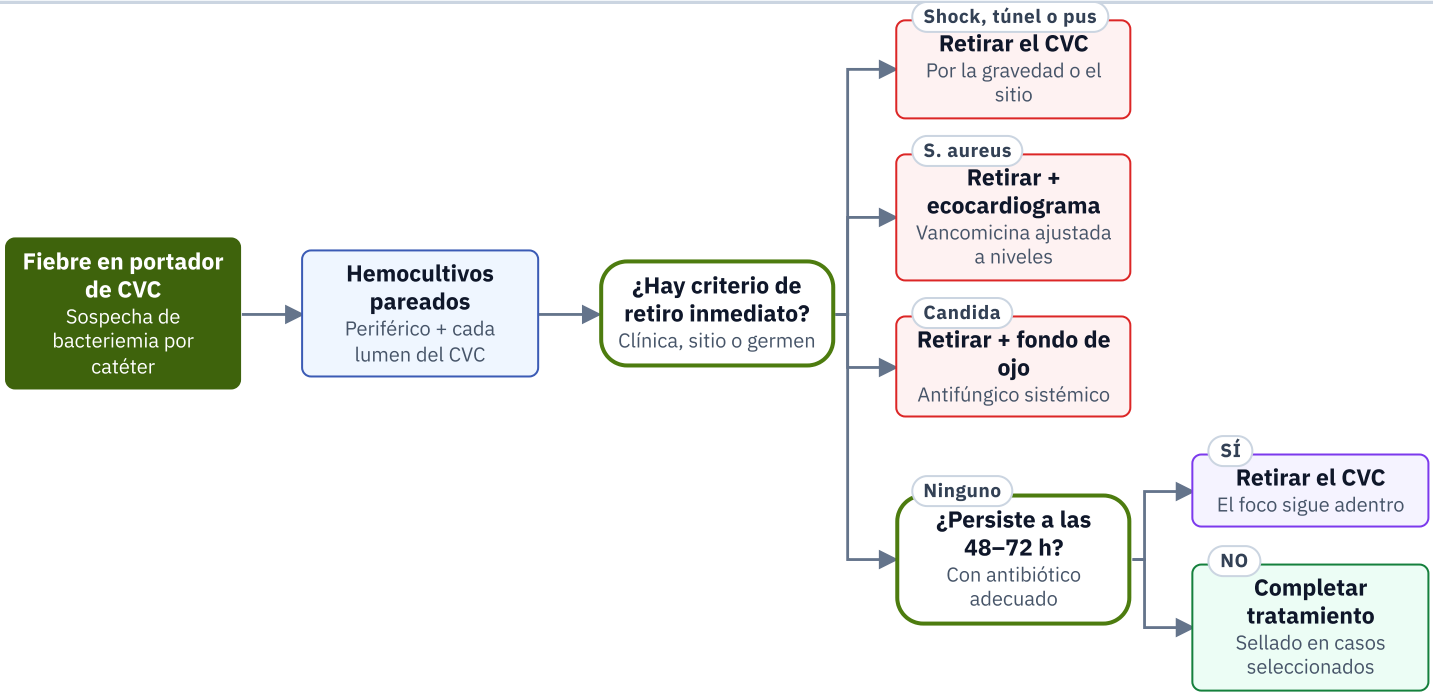


TABLA 2.3 · TIPOS DE AISLAMIENTO HOSPITALARIO EUNACOM: PATÓGENOS Y MEDIDAS OBLIGATORIAS

TIPO DE AISLAMIENTO	MEDIDAS Y EPP OBLIGATORIO	HABITACIÓN REQUERIDA	PATÓGENOS CLÁSICOS EUNACOM
Contacto	Guantes + Pechera/Bata plástica al entrar	Individual o cohorte de misma bacteria	Clostridioides difficile, SAMR, VRE, BLEE, Sarna
Gotitas	Mascarilla quirúrgica al entrar al box	Separación > 1 metro entre camas	Meningococo, Influenza, Coqueluche, Parotiditis
Aéreo (Respiratorio)	Mascarilla N95 / FFP2 con sello hermético	Presión negativa + puerta cerrada obligatoria	Tuberculosis bacilífera, Sarampión, Varicela activa
Protector (Inverso)	Mascarilla quirúrgica + bata limpia + no flores	Presión positiva (flujo laminar)	Neutropenia severa (RAN < 500), Trasplante médula

REGLA DE ORO **Aéreo: TBC, sarampión, varicela** — N95 + presión negativa

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **19–22, 30–32** (págs. 10–12) · solucionario págs. 23, 25.

Clase 2.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

2.4 Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

Rentabilidad media · diferenciación por periodo de incubación y toxinas bacterianas

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.026 **Toxicoinfección alimentaria** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Cólera · Prevención de enfermedades entéricas

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Incubación < 6 horas con vómitos predominantes y sin fiebre**: enterotoxina preformada (S. aureus en mayonesas o B. cereus en arroz).
- **Incubación de 8 a 16 horas con diarrea y cólicos**: Clostridium perfringens (carnes y guisos recalentados).
- **Incubación > 16 horas con fiebre**: invasión bacteriana (Salmonella o Campylobacter).
- **Cólera**: diarrea acuosa masiva en "agua de arroz" con deshidratación fulminante; tratamiento es rehidratación agresiva + Doxiciclina dosis única.
- **Botulismo**: parálisis flácida simétrica descendente que inicia con diplopía, ptosis y disfagia tras consumir conservas caseras.
- El tratamiento del botulismo es soporte en UCI y ANTITOXINA BOTULÍNICA endovenosa precoz.



HECES EN AGUA DE ARROZ
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · PACIENTE QUE ENFERMA DESPUÉS DE UNA COMIDA

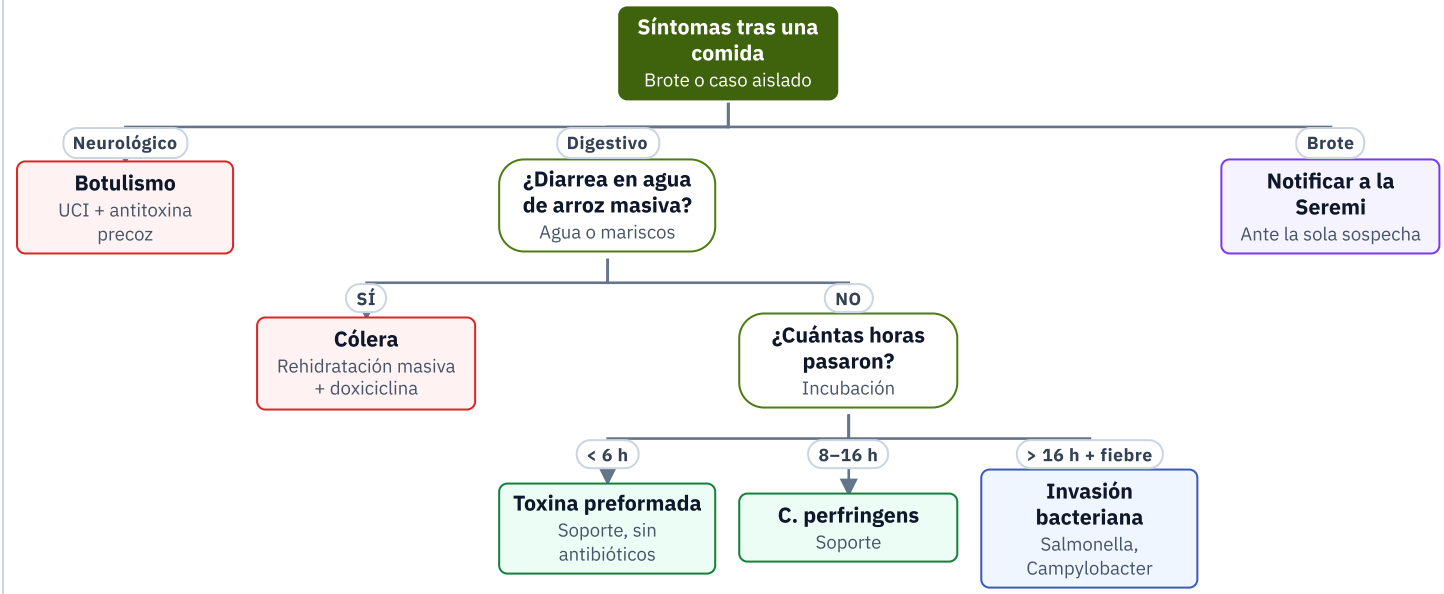


TABLA 2.4 · TOXICOINFECCIONES ALIMENTARIAS: GUÍA RÁPIDA POR ALIMENTO Y TIEMPO DE INCUBACIÓN

MICROORGANISMO	PERÍODO INCUBACIÓN	ALIMENTO PROTOTÍPICO	MANIFESTACIÓN CARDINAL
Staphylococcus aureus	1 a 6 horas (muy rápido)	Mayonesa casera, cremas, pastelería	Vómitos intensos incoercibles, sin fiebre
Bacillus cereus (emético)	1 a 5 horas	Arroz frito o recalentado chino	Náuseas y vómitos explosivos
Clostridium perfringens	8 a 16 horas	Carnes guisadas, estofados recalentados	Dolor cólico intenso y diarrea, sin vómitos
Salmonella no tifoidea	12 a 48 horas	Huevos crudos, mayonesa, pollo crudo	Fiebre alta, vómitos y diarrea con estrías
Vibrio cholerae	12 a 72 horas	Agua contaminada, mariscos crudos	Diarrea profusa en agua de arroz sin dolor
Clostridium botulinum	12 a 36 horas	Conservas caseras, vegetales enlatados	Parálisis flácida descendente + diplopía

REGLA DE ORO **< 6 h, vómitos sin fiebre** — Toxina preformada: aureus o cereus

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **33–36** (págs. 12–13) · solucionario págs. 25–26.

Clase 2.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

3.1 Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.014 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA) — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: VIH en ginecobstetricia · Infecciones por HIV

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ley del SIDA**: test de VIH es voluntario, confidencial y requiere consentimiento informado firmado.
- El diagnóstico definitivo en Chile lo realiza EXCLUSIVAMENTE el Instituto de Salud Pública (ISP); nunca rotular con un test rápido local.
- **Estrategia actual**: TARV universal e inmediata a todo paciente confirmado, sin importar el nivel de CD4.
- **Esquema preferente de primera línea en Chile**: Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir (TDF/3TC/DTG) en dosis única diaria.
- Dolutegravir es un inhibidor de integrasa con alta barrera genética y rápida supresión viral.
- **Indetectable** = Intransmisible (I=I): si la carga viral es < 50 copias/mL por **6 meses** continuos, el riesgo de transmisión sexual es cero.

ALGORITMO · VIH: DE LA SOSPECHA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 3.1 · ETAPIFICACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO DEL VIH (CDC)

RECUENTO LINFOCITOS CD4+	CATEGORÍA A (ASINTOMÁTICO / SRA)	CATEGORÍA B (SINTOMÁTICO NO A NI C)	CATEGORÍA C (CONDICIÓN SIDA)
≥ 500 células/mm³ (≥ 26%)	Etapa A1	Etapa B1	Etapa C1 (SIDA)
200 a 499 células/mm³ (14–25%)	Etapa A2	Etapa B2	Etapa C2 (SIDA)
< 200 células/mm³ (< 14%)	Etapa A3 (SIDA por CD4)	Etapa B3 (SIDA por CD4)	Etapa C3 (SIDA clínico y lab)
Enfermedades Prototípicas	Linfadenopatía persistente, SRA	Candidiasis oral (muguet), leucoplasia oral vellosa, herpes zóster recurrente	Pneumocystis, Toxoplasmosis cerebral, Criptococo, TBC extrapulmonar, Sarcoma Kaposi

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Test rápido o ELISA reactivo	2.ª muestra venosa al ISP	Informar VIH e iniciar TARV
Tamizaje negativo con exposición reciente	Repetir en 3 meses	Descartar la infección
VIH confirmado con CD4 altos	TARV inmediata	Esperar a que bajen los CD4

REGLA DE ORO **Voluntario, confidencial, con consentimiento** — Firmado

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **38–40** (pág. 13) · solucionario pág. 26.

Clase 3.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

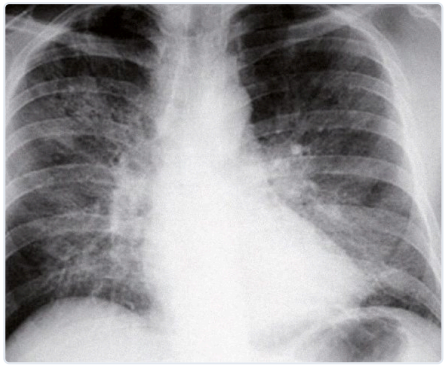
★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.014 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA) — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Neumonías en inmunosuprimidos · Prevención de infecciones oportunistas en VIH (+) · Candidiasis oral y esofágica · Detección de antígeno de Cryptococcus en LCR y test de tinta china · Diarrea en inmunosuprimidos · Prevención de infecciones con énfasis en inmunosuprimidos · Antigenemia

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Pneumocystis jirovecii**: tos seca, disnea subaguda, infiltrado intersticial bilateral en alas de mariposa y LDH elevada.
- **Tratamiento de Pneumocystis**: Cotrimoxazol a dosis altas por **21 días**.
- **CORTICOIDES en Pneumocystis**: obligatorios si PaO2 < **70 mmHg** o Gradiente A-a **≥ 35 mmHg**.
- **Masa cerebral con realce en anillo en paciente VIH**: Toxoplasmosis cerebral (ganglios basales); iniciar prueba terapéutica con Sulfadiazina + Pirimetamina.
- **Meningitis por Cryptococcus neoformans**: Tinta China (+) en LCR; tratamiento con Anfotericina B + Flucitosina.



PNEUMOCYSTIS
Manual AMIR Infecciosas, p. 152

ALGORITMO · VIH AVANZADO: QUÉ ÓRGANO Y QUÉ CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

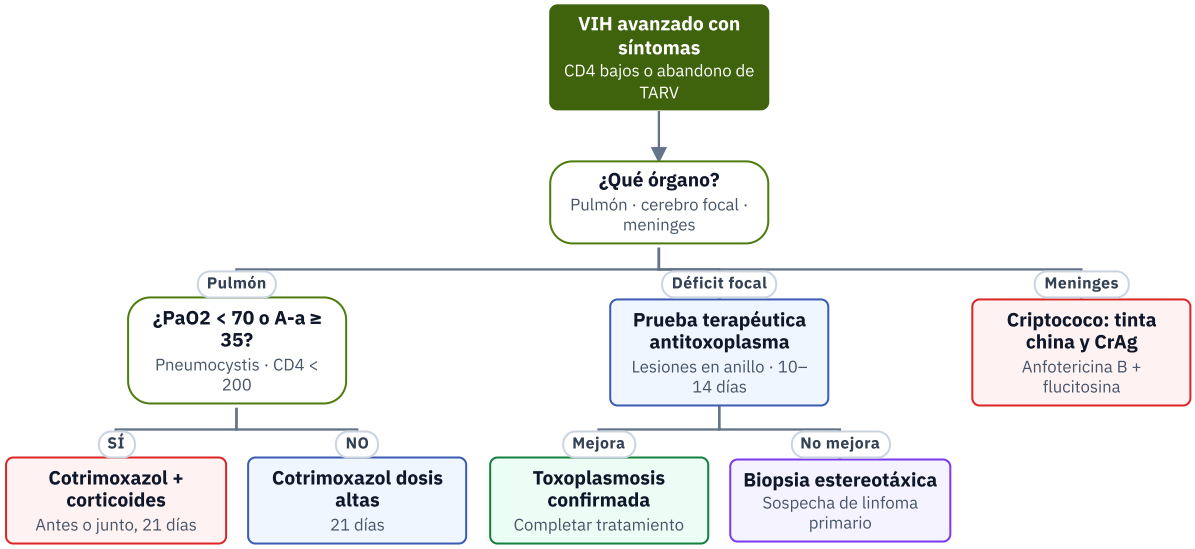


TABLA 3.2 · PROFILAXIS PRIMARIA DE INFECCIONES OPORTUNISTAS EN VIH SEGÚN UMBRAL DE CD4

NIVEL DE LINFOCITOS CD4+	PATÓGENO BLANCO	FÁRMACO PROFILÁCTICO DE ELECCIÓN	CRITERIO DE SUSPENSIÓN
CD4 < 200 células/mm³ (o < 14%)	Pneumocystis jirovecii	Cotrimoxazol fuerte (TMP/SMX 160/800 mg) 1 comp/día	CD4 > 200 por ≥ 3 meses continuos con TARV
CD4 < 100 células/mm³ + IgG (+)	Toxoplasma gondii	Cotrimoxazol fuerte 1 comp/día (misma dosis que PCP)	CD4 > 200 por ≥ 3 meses continuos con TARV
CD4 < 50 células/mm³	Mycobacterium avium complex (MAC)	Azitromicina 1.200 mg oral una vez por semana	CD4 > 100 por ≥ 3 meses continuos con TARV
Cualquier CD4 con PPD ≥ 5 mm	Mycobacterium tuberculosis	Isoniazida 300 mg/día + Piridoxina por 9 meses	Al completar los 9 meses de quimioprofilaxis

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Pneumocystis con PaO2 < 70 o A-a ≥ 35	Cotrimoxazol + corticoides antes o junto	Solo antibiótico, o corticoide después
Lesiones en anillo en ganglios basales	Prueba terapéutica antitoxoplasma	Biopsia o radioterapia de entrada
Sin respuesta a los 14 días	Biopsia estereotáxica: linfoma primario	Seguir con el mismo tratamiento

REGLA DE ORO **CD4 < 200: Pneumocystis** — < 100: toxoplasma y criptococo · < 50: MAC

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **37, 41–43** (págs. 13–14) · solucionario págs. 26–27.

Clase 3.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

3.3 Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

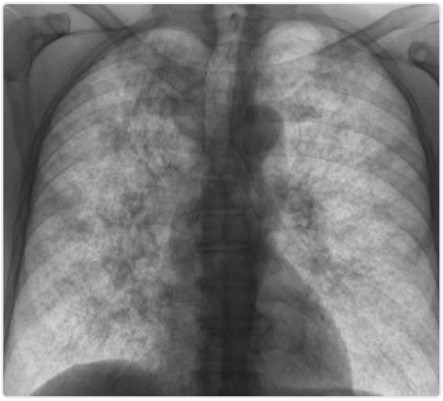
★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.028 **Tuberculosis extrapulmonar** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Tuberculosis pulmonar · Derrame pleural por tuberculosis · Tuberculosis pulmonar (fracaso de tratamiento) · Infección urinaria específica

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Pleuritis TBC**: derrame pleural exudado linfocítico con ADA > **40 UI**/L (valor diagnóstico confirmatorio).
- **GeneXpert**: PCR en tiempo real que confirma M. tuberculosis y detecta resistencia a Rifampicina en < **2 horas**.
- **Esquema primario estándar en Chile**: **2 meses** de 4 fármacos (RHZE) seguidos de **4 meses** de 2 fármacos (RH).
- Isoniazida causa neuropatía periférica por déficit de vitamina B6; se previene con Piridoxina oral.
- Etambutol causa neuritis óptica retrobulbar con pérdida de la visión de colores verde-rojo; exige suspensión inmediata.



TUBERCULOSIS MILIAR (RX)
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 66

ALGORITMO · TUBERCULOSIS: CONFIRMAR Y TRATAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

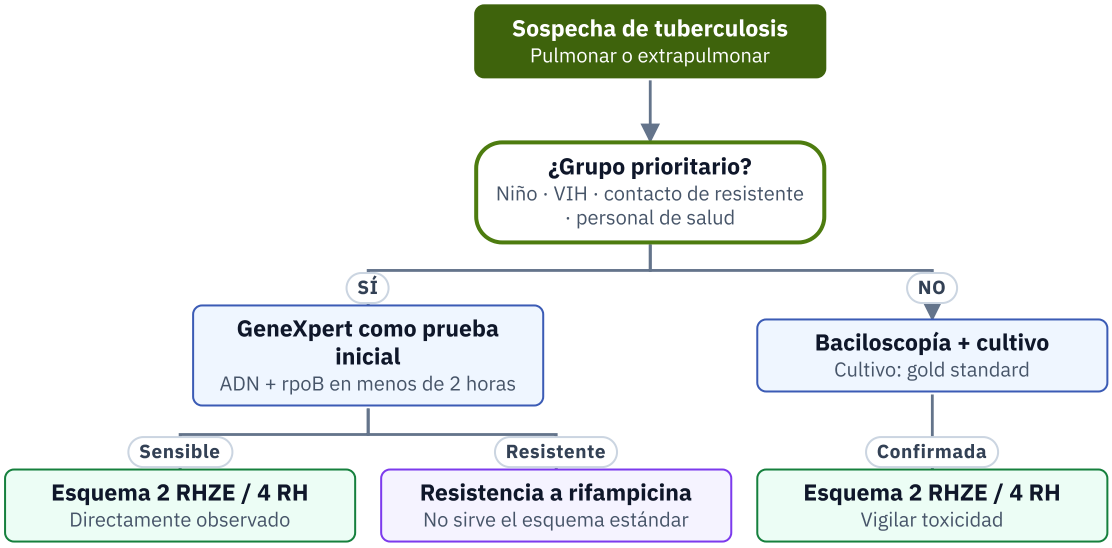


TABLA 3.3 · FARMACOLOGÍA ANTITUBERCULOSA DE PRIMERA LÍNEA: MECANISMOS Y EFECTOS ADVERSOS

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	EFECTO ADVERSO PRINCIPAL	MANEJO / PREVENCIÓN
Isoniazida (H)	Inhibe síntesis de ácido micólico	Neuropatía periférica y hepatitis	Coadministrar Piridoxina (Vitamina B6)
Rifampicina (R)	Inhibe ARN polimerasa bacteriana	Secreciones naranjas e inducción CYP450	Educar al paciente sobre orina naranja
Pirazinamida (Z)	Disrumpe potencial de membrana	Hepatotoxicidad severa e hiperuricemia	Monitorizar función hepática y ácido úrico
Etambutol (E)	Inhibe arabinosil transferasa	Neuritis óptica (discromatopsia rojo-verde)	Control de agudeza visual; suspender de inmediato

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

HALLAZGO	RESPONSABLE	CONDUCTA CORRECTA
Orina o lágrimas naranjas	Rifampicina	Tranquilizar y continuar el esquema
Parestesias en pies y manos	Isoniazida	Piridoxina (vitamina B6)
Crisis de gota, ácido úrico alto	Pirazinamida	Controlar ácido úrico y función hepática

REGLA DE ORO **Derrame linfocítico + ADA > 40** — Pleuritis tuberculosa

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **44–46** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

Clase 3.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.023 **Sífilis secundaria, terciaria y congénita** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Enfermedades de transmisión sexual · Serología de enfermedades infecciosas · Sífilis congénita · VDRL - MHATP

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Chancro sifilítico (primaria)**: úlcera única, base indurada, fondo limpio e INDOLORA.
- **Secundarismo sifilítico**: exantema maculopapular con compromiso palmo-plantar y condilomas planos perianales.
- VDRL/RPR es cuantitativo y sirve para evaluar actividad y respuesta al tratamiento (cura = caída de **4 veces** los títulos).
- Las pruebas treponémicas (FTA-ABS) quedan positivas de por vida ("cicatriz serológica") y confirman el diagnóstico.
- **Sífilis precoz (< 1 año)**: Penicilina Benzatina 2.4 MU IM en DOSIS ÚNICA.



CHANCRO
CDC PHIL 6803 (CDC/M. Rein), dominio público

ALGORITMO · SÍFILIS: DE LA SEROLOGÍA A LA PENICILINA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

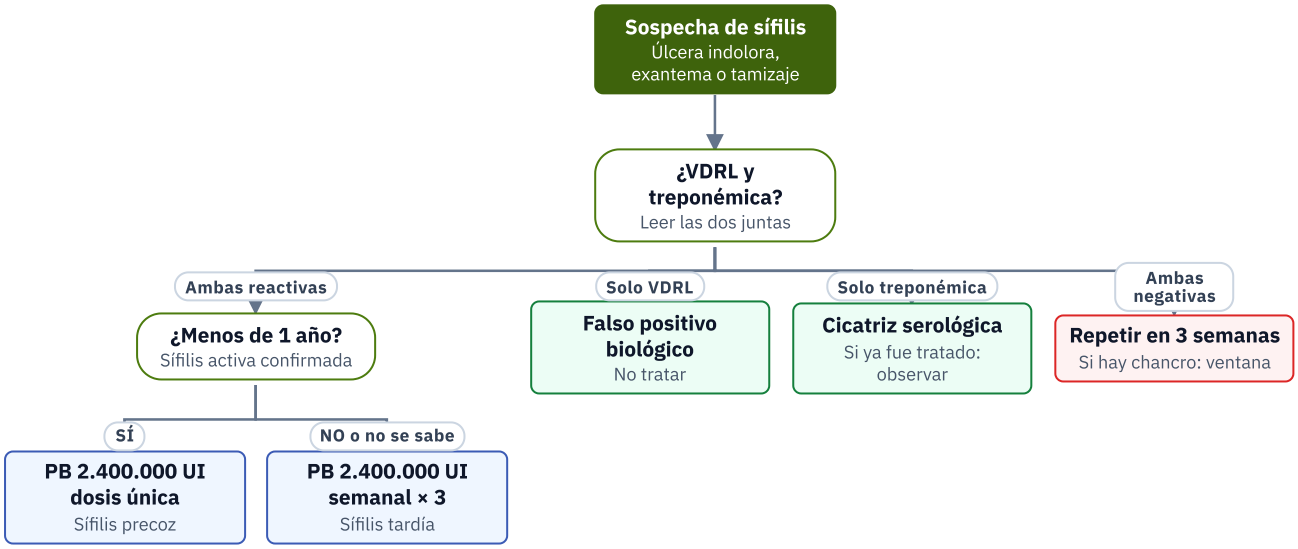


TABLA 3.4 · INTERPRETACIÓN DE ALGORITMOS SEROLÓGICOS DE SÍFILIS

PRUEBA NO TREPONÉMICA (VDRL/RPR)	PRUEBA TREPONÉMICA (FTA-ABS/ELISA)	INTERPRETACIÓN CLÍNICA	CONDUCTA RECOMENDADA
Reactivo (ej. 1:16)	Reactiva	Sífilis activa confirmada	Tratar según tiempo de evolución
Reactivo (ej. 1:2)	No Reactiva	Falso positivo biológico	No tratar; causas: autoinmune, embarazo, edad
No Reactivo	Reactiva	Cicatriz serológica o sífilis primaria muy precoz	Si tratado previamente: observar; si no: evaluar
No Reactivo	No Reactiva	Paciente no infectado (o período de ventana)	Repetir en 3 semanas si hay chancro sospechoso

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Secundaria (exantema palmoplantar)	PB 2.400.000 UI dosis única	Tres dosis semanales
Latente de duración desconocida	PB semanal × 3 semanas	Dosis única
Control después de tratar	VDRL cuantitativo a los 6 y 12 meses	Controlar con FTA-ABS

REGLA DE ORO **Úlcera indolora = chancro** — Exantema palmoplantar = secundaria

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **47–49** (págs. 14–15) · solucionario págs. 27–28.

Clase 3.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.010 Enfermedades de transmisión sexual — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Condilomas · Prevención de enfermedades de transmisión sexual · Tinción de Gram · Factores de riesgo y prevención de ETS

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Uretritis gonocócica**: secreción purulenta abundante; Gram con diplococos Gram negativos intracelulares.
- **Uretritis no gonocócica (Chlamydia)**: secreción serosa o escasa, incubación larga, Gram sin bacterias visibles.
- **Toda uretritis exige tratamiento combinado empírico**: Ceftriaxona **500 mg** IM (gonococo) + Doxiciclina **100 mg** c/**12h** x **7 días** (clamidia).
- **Úlcera dolorosa en racimo sobre base eritematosa**: Herpes genital (tratar con Aciclovir oral).
- **Úlcera indolora, base indurada y limpia**: Sífilis primaria (tratar con Penicilina Benzatina dosis única).

ALGORITMO · ITS: DEL SÍNDROME A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

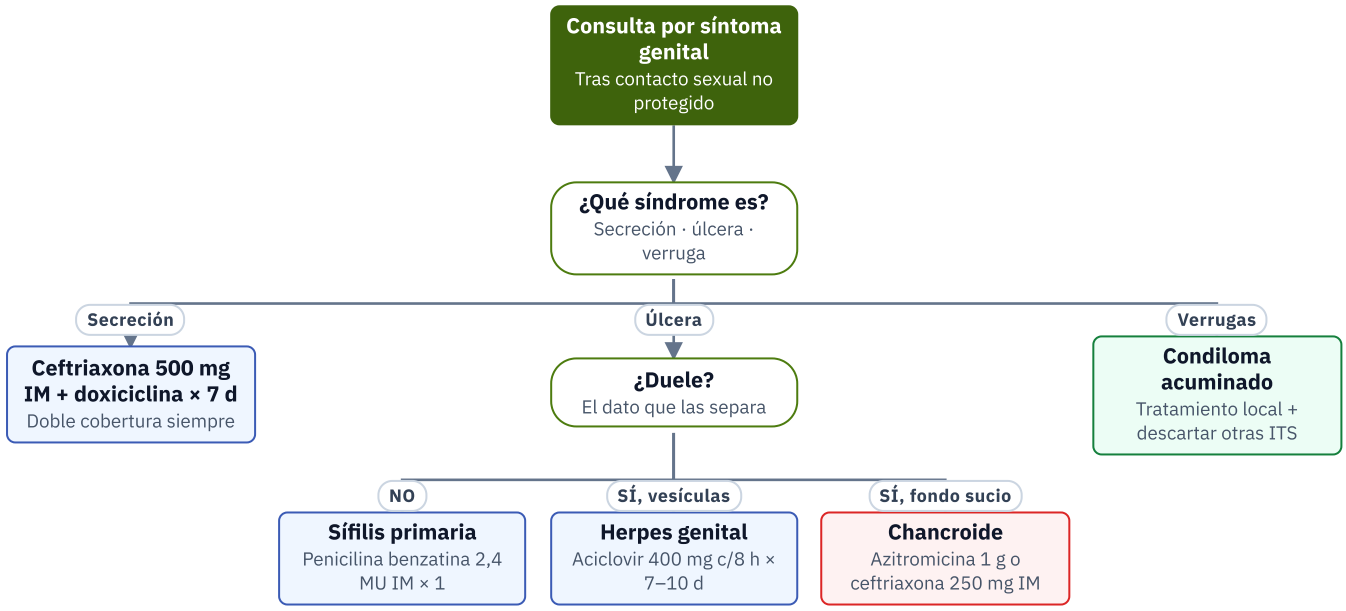


TABLA 3.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ÚLCERAS GENITALES EN EUNACOM

CARACTERÍSTICA	HERPES GENITAL (VHS-2)	SÍFILIS PRIMARIA (CHANCRO DURO)	CHANCROIDE (CHANCRO BLANDO)
Etiología	Virus Herpes Simplex tipo 2 (o 1)	Treponema pallidum	Haemophilus ducreyi
Número de lesiones	Múltiples vesículas agrupadas en racimo	Habitualmente única	Múltiples (autoinoculables)
Dolor local	Muy dolorosas	Completamente indolora	Intensamente dolorosa
Fondo de la úlcera	Eritematoso limpio tras romperse	Limpio con base indurada y firme	Sucio, purulento y necrótico
Adenopatía regional	Sensible bilateral	Indolora, firme y bilateral	Dolorosa con tendencia a fistulizar (bubón)
Tratamiento de elección	Aciclovir oral 400 mg c/8h x 7-10 d	Penicilina Benzatina 2.4 MU IM x 1	Azitromicina 1 g oral o Ceftriaxona 250 mg IM

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Gram con diplococos Gram (–)	Ceftriaxona + doxiciclina	Tratar solo el gonococo
Uretritis escasa, Gram sin bacterias	Pensar en Chlamydia · mismo esquema doble	Descartar ITS por el Gram
Uretritis gonocócica	Ceftriaxona IM	Ciprofloxacino

REGLA DE ORO **Gram (–) intracelular = gonococo** — Gram sin bacterias = clamidia

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **50–54** (pág. 15) · solucionario pág. 28.

Clase 3.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

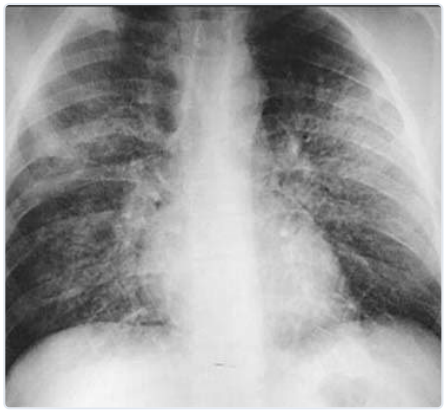
4.1 Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.04.2.008 Síndrome pulmonar por Hanta Virus — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Reservorio de Hantavirus en Chile**: Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga); contagio por inhalación de orina/heces secas.
- **Tríada de sospecha en hemograma**: Trombocitopenia + Hemoconcentración (Hto alto) + Inmunoblastos > **10%**.
- Mialgias muy intensas con predilección por muslos y región lumbar.
- **Regla terapéutica de oro**: MANEJO RESTRICTIVO DE FLUIDOS para evitar inundación alveolar por fuga capilar.
- **Soporte avanzado de rescate**: ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) veno-arterial.
- Es una Enfermedad de Notificación Obligatoria (ENO) de carácter INMEDIATO.



EDEMA INTERSTICIAL INICIAL
Guía Clínica Hantavirus MINSAL 2009, Fig. 7

ALGORITMO · HANTAVIRUS: SOSPECHA Y TRASLADO PRECOZ

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

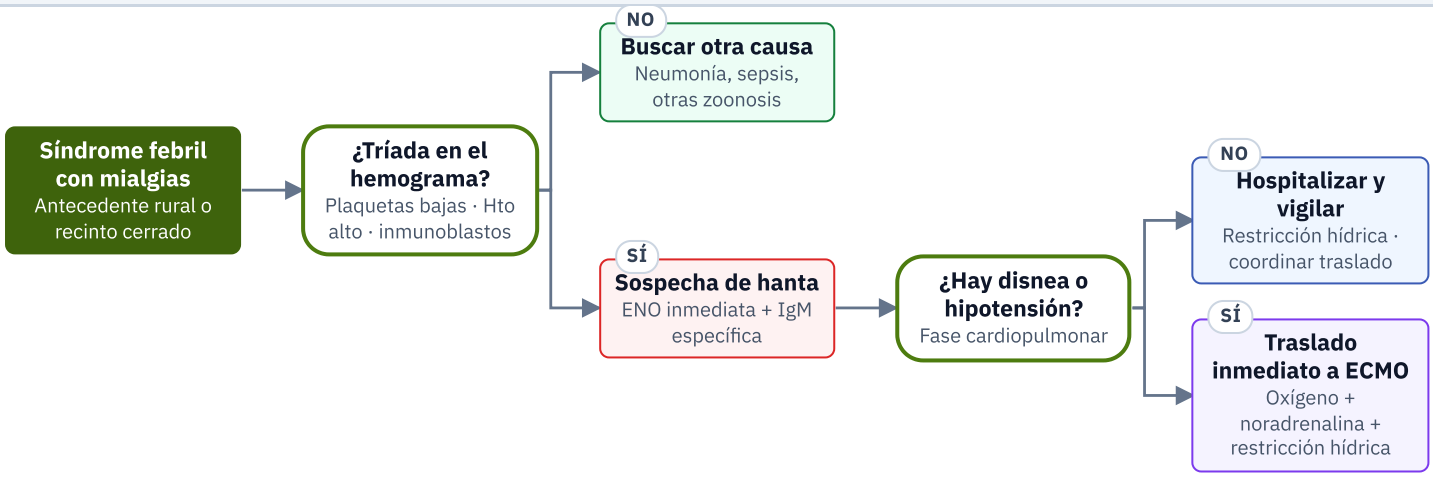


TABLA 4.1 · HANTAVIRUS (SCPH) VS NEUMONÍA GRAVE VS SEPSIS BACTERIANA

PARÁMETRO	HANTAVIRUS (SCPH)	NEUMONÍA GRAVE COMUNITARIA	SHOCK SÉPTICO CLÁSICO
Antecedente clave	Ruralidad, cabaña cerrada, colilargo	Brote comunitario invernal	Foco infeccioso evidente (piel, ITU)
Mialgias	Intensas en muslos y dorso lumbar	Mialgias generalizadas leves	Variable, no predominante
Hemograma patognomónico	Plaquetas < 100k + Hto > 50% + Inmunoblastos	Leucocitosis con neutrofilia, Hto normal	Leucocitosis con neutrofilia y desviación
Manejo de fluidos	RESTRICCIÓN ESTRICTA (evitar sobrecarga)	Aporte hídrico estándar según balance	Carga agresiva inicial (30 mL/kg)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hipotensión en sospecha de hanta	Noradrenalina precoz	Bolo de cristaloides 30 mL/kg
Inicio de la disnea	Trasladar ya a centro con ECMO	Esperar el shock para derivar
Sospecha clínica	Notificar de inmediato (ENO)	Esperar la IgM para notificar

REGLA DE ORO — **Recinto cerrado rural** — Inhalación de excretas del colilargo

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **56–58** (págs. 15–16) · solucionario pág. 29.

Clase 4.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

4.2 Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

1.04.4.016 Serología de enfermedades infecciosas — Interpreta y emplea

También: Miocardiopatías

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Vía de transmisión más frecuente actual en Chile**: vertical / congénita transplacentaria.
- **Tamizaje prenatal con serología IgG**: universal y obligatorio en zonas endémicas (desde O'Higgins al norte).
- **Diagnóstico en recién nacido / fase aguda**: método PARASITOLÓGICO DIRECTO (microhematocrito) o PCR.
- **Diagnóstico en fase crónica**: SEROLOGÍA (dos técnicas IgG positivas: ELISA + IFI).
- **Cardiopatía chagásica**: Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD) + Hemibloqueo Anterior Izquierdo (HBAI).



VINCHUCA
Wikimedia Commons, dominio público

ALGORITMO · CHAGAS: QUÉ EXAMEN Y A QUIÉN TRATAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

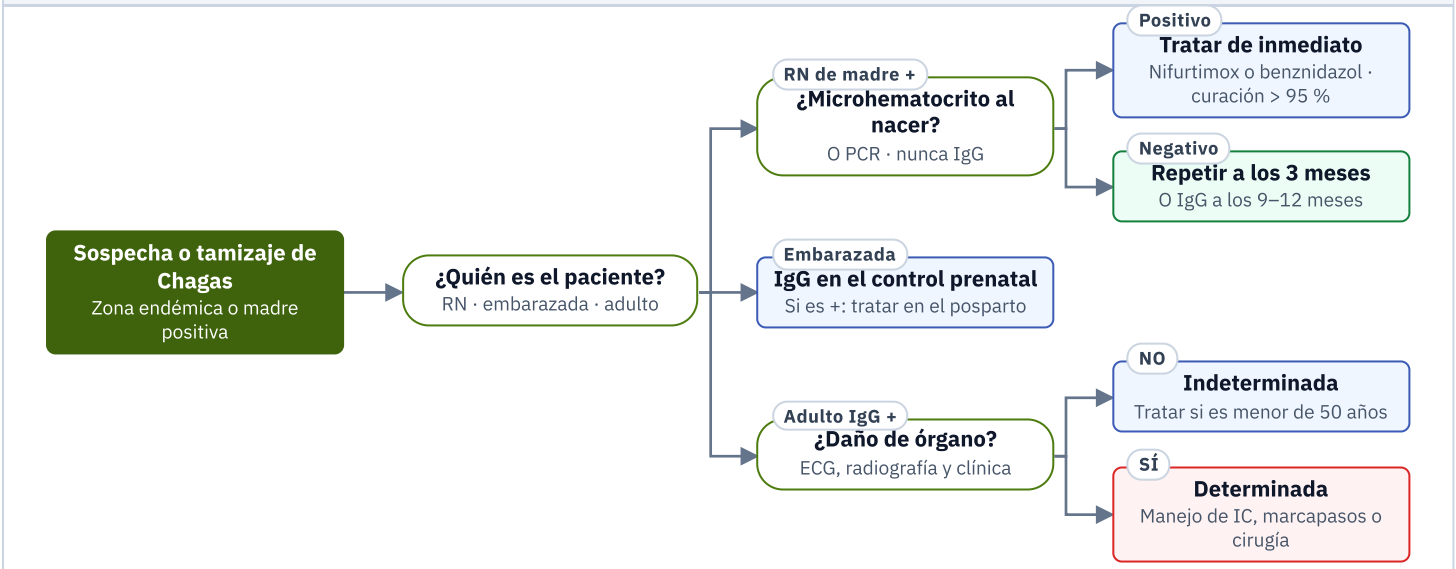


TABLA 4.2 · DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS SEGÚN LA FASE CLÍNICA

FASE CLÍNICA	MÉTODO DIAGNÓSTICO DE ELECCIÓN	MANIFESTACIÓN TÍPICA	INDICACIÓN DE FÁRMACO ANTIPARASITARIO
Aguda / Congénita	Parasitológico directo (Microhematocrito) / PCR	Signo de Romaña o asintomático en RN	Indicación absoluta: Nifurtimox o Benznidazol
Crónica Indeterminada	Serología IgG por 2 técnicas (ELISA + IFI)	Completamente asintomático (ECG normal)	Indicado en < 50 años para prevenir progresión
Cardiopatía Chagásica	Serología IgG + ECG + Ecocardiograma	BCRD + HBAI, arritmias ventriculares, IC	Manejo de IC / Marcapasos (parasiticida discutido)
Megacolon / Megaesófago	Serología IgG + Rx baritada / TAC	Constipación pertinaz, fecalomas, disfagia	Manejo de la constipación, cirugía de resección

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
RN de madre con Chagas	Microhematocrito o PCR al nacer	Pedir IgG al recién nacido
Adulto con sospecha de Chagas crónico	Dos serologías IgG distintas	Buscar el parásito en sangre
Embarazada IgG positiva	Tratar después del parto + estudiar al RN	Nifurtimox durante el embarazo

REGLA DE ORO **Vía predominante: congénita** — Vinchuca domiciliaria interrumpida en 1999

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **59–60** (pág. 16) · solucionario pág. 29.

Clase 4.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

4.3 Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.04.1.008 Dengue — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Malaria

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Dengue**: dolor retroorbitario + mialgias severas ("quebrantahuesos") + exantema con islas de piel sana.
- **Signos de alarma de Dengue**: dolor abdominal persistente, vómitos, sangrado mucoso, letargia y aumento del Hto con caída de plaquetas.
- En Dengue están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS los AINEs y la Aspirina por riesgo de hemorragia; solo usar Paracetamol.
- **Malaria**: sospechar en viajero procedente de zona endémica con accesos febriles paroxísticos, anemia hemolítica e ictericia.
- **Diagnóstico de certeza de Malaria**: GOTA GRUESA y frotis teñido con Giemsa.



EXANTEMA DEL DENGUE
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 134

ALGORITMO · FIEBRE EN EL VIAJERO QUE VUELVE DEL TRÓPICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

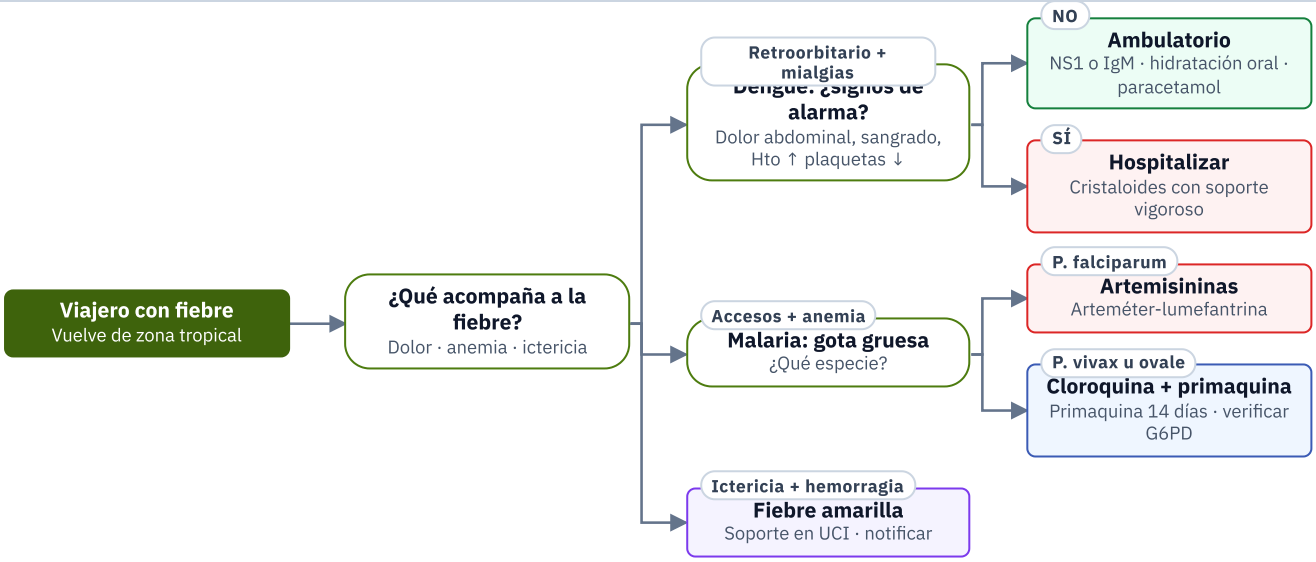


TABLA 4.3 · ENFERMEDADES FEBRILES TROPICALES DEL VIAJERO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EUNACOM

ENFERMEDAD	VECTOR Y PATÓGENO	CLÍNICA PROTOTÍPICA	EXAMEN CONFIRMATORIO	TERAPIA DE ELECCIÓN
Dengue	Aedes aegypti · Flavivirus	Dolor retroorbitario + mialgias + exantema	Antígeno NS1 (< 5 d) / IgM (> 5 d)	Soporte con hidratación EV (prohibido AINEs)
Malaria (P. falciparum)	Anopheles hembra · Plasmodium	Paroxismos febriles + anemia + ictericia	Gota gruesa y frotis sanguíneo	Derivados de Artemisinina (Arteméter)
Malaria (P. vivax)	Anopheles · Plasmodium vivax	Accesos febriles cada 48 h (terciana)	Gota gruesa (trofozoítos en anillo)	Cloroquina + Primaquina (cura hipnozoítos)
Fiebre Amarilla	Haemagogus / Aedes · Flavivirus	Fiebre + ictericia intensa + hemorragias	Serología IgM / PCR viral	Soporte intensivo en UCI (vacuna preventiva)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hematocrito ↑ con plaquetas < 100.000	Hospitalizar con cristaloides	Seguir en forma ambulatoria
Fiebre con anemia en viajero	Gota gruesa y frotis	Solo serología de dengue
Embarazada que viaja a zona selvática	No vacunar contra fiebre amarilla	Vacunar igual

REGLA DE ORO **Retroorbitario, mialgias, islas blancas** — En un viajero del trópico

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **61–64** (pág. 16) · solucionario págs. 29–30.

Clase 4.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
7 preguntas reales 2013–2025

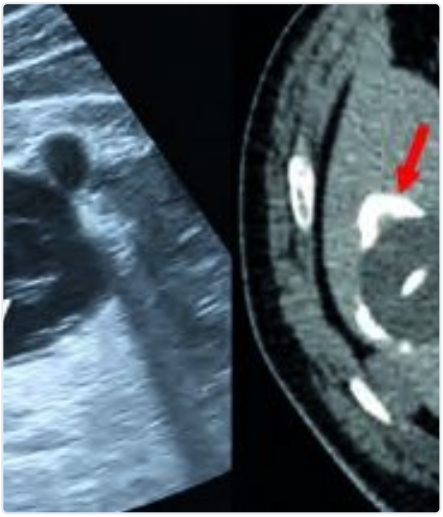
Alta rentabilidad · quiste hidatídico hepático (PAIR vs cirugía) y triada de triquinosis con eosinofilia

1.04.1.013 Hidatidosis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Triquinosis · Hidatidosis pulmonar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Hidatidosis**: el perro es el hospedero definitivo; el humano se contagia al ingerir huevos de las heces caninas.
- **Quiste hidatídico hepático**: imagen ecográfica clásica de membranas desprendidas (Signo del Camalote).
- **Rotura de quiste hidatídico**: provoca SHOCK ANAFILÁCTICO y diseminación secundaria (peritoneal).
- **Triquinosis**: antecedente de consumo de cecinas o carne de cerdo casera sin inspección sanitaria.
- **Tríada de Triquinosis**: Edema bipalpebral bilateral + Mialgias severas + Fiebre.
- **Laboratorio patognomónico de Triquinosis**: EOSINOFILIA MASIVA (> **20-50%**) y CPK elevada.
- **Tratamiento de elección en ambas entidades**: Albendazol oral.



QUISTE EN LA ECOGRAFÍA
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 43

ALGORITMO · ZOONOSIS PARASITARIA RURAL: QUISTE O MÚSCULO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

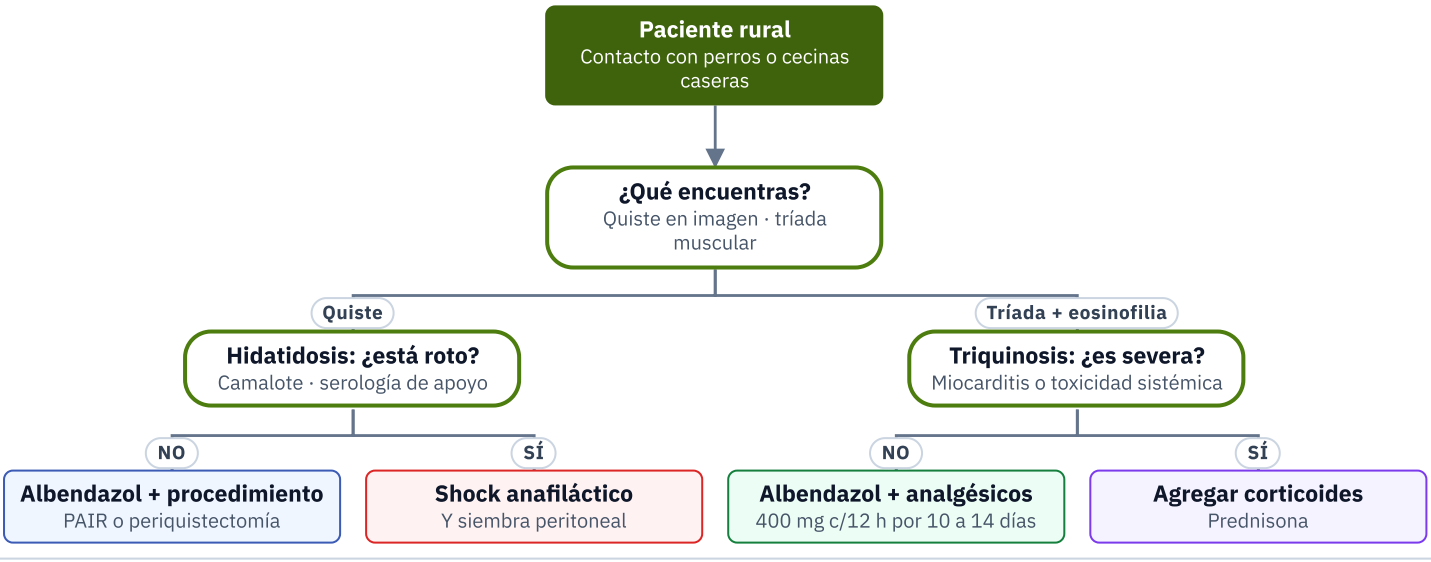


TABLA 4.4 · HIDATIDOSIS VS TRIQUINOSIS: CUADRO RESUMEN EUNACOM

CARACTERÍSTICA	HIDATIDOSIS (ECHINOCOCCUS GRANULOSUS)	TRIQUINOSIS (TRICHINELLA SPIRALIS)
Fuente de contagio	Contacto con heces de perro / agua con huevos	Carne de cerdo o cecinas caseras crudas
Órgano blanco principal	Hígado (70%) y Pulmón (20%)	Músculo estriado (diafragma, maseteros)
Manifestación cardinal	Masa quística indolora / hallazgo ecográfico	Edema bipalpebral + mialgias + fiebre
Hallazgo clave de laboratorio	Imagen en camalote / serología IgG	Eosinofilia masiva (> 20-50%) + CPK elevada
Complicación más temida	Rotura de quiste con shock anafiláctico	Miocarditis o encefalitis por migración
Fármaco antiparasitario	Albendazol + procedimiento PAIR o Cirugía	Albendazol oral + Corticoides si severo

REGLA DE ORO **Huevos de heces de perro** — Hígado primero, pulmón después

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **55, 65–68** (págs. 15, 17) · solucionario págs. 28, 30.

Clase 4.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

4.5 Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

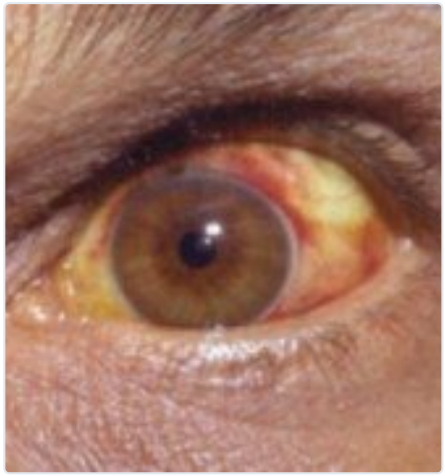
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.004 Brucelosis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Leptospirosis · Fiebre tifoídea y paratifoídea · Infecciones por Salmonella

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Brucelosis**: antecedente de consumo de quesos de cabra no pasteurizados; fiebre ondulante y sudoración con olor a paja húmeda.
- **Complicación osteoarticular más frecuente de brucelosis**: Sacroileítis y Espondilodiscitis lumbar.
- **Tratamiento de Brucelosis**: Doxiciclina + Rifampicina por **6 semanas** completas (biterapia obligatoria).
- **Leptospirosis**: contacto con aguas estancadas/inundaciones contaminadas con orina de roedores; cursa con sufusión conjuntival y mialgias en pantorrillas.
- **Síndrome de Weil**: ictericia + falla renal oligúrica hipokalémica + hemorragia pulmonar; tratar con Penicilina G o Ceftriaxona EV.
- **Fiebre tifoidea**: disociación esfigmotérmica (Signo de Faget: fiebre alta con bradicardia relativa); tratamiento de elección es Ceftriaxona.



SUFUSIÓN CONJUNTIVAL
Wikimedia Commons, CC BY 4.0

ALGORITMO · FIEBRE PROLONGADA: LA EXPOSICIÓN DECIDE

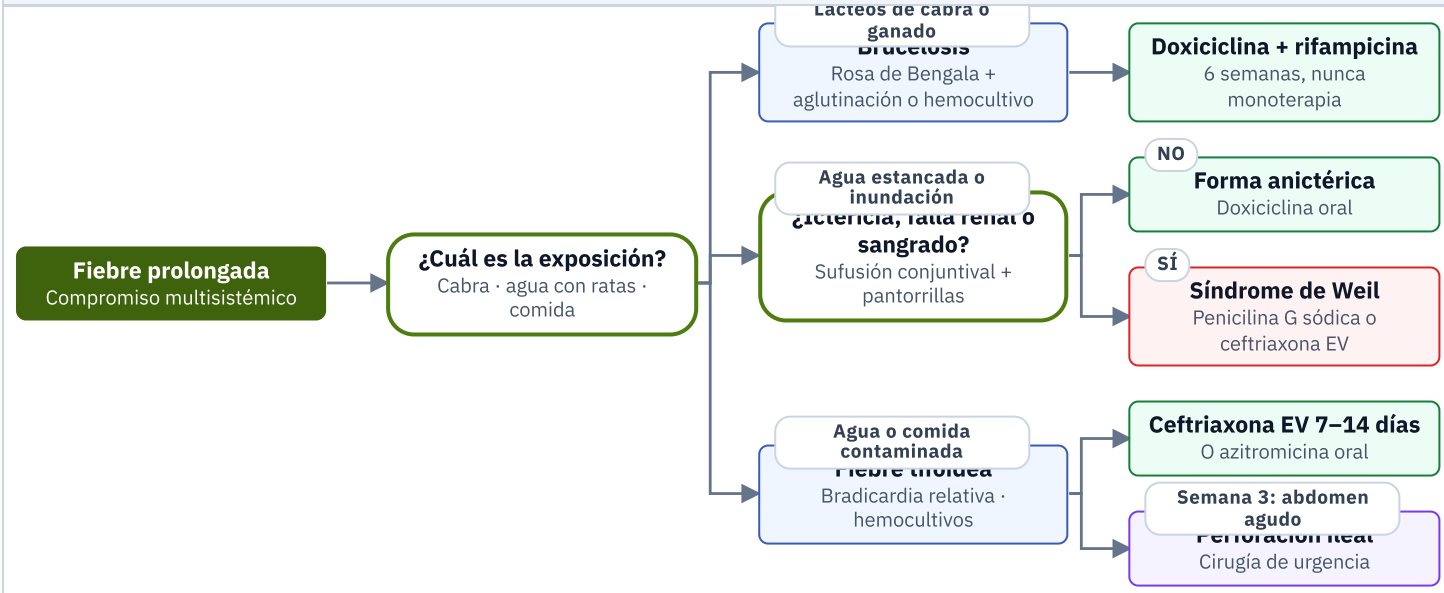


TABLA 4.5 · BACTERIOSIS ZOONÓTICAS: FACTORES DE EXPOSICIÓN Y SIGNOS CARDINALES EUNACOM

ENFERMEDAD	AGENTE Y FUENTE DE EXPOSICIÓN	SIGNO CLÍNICO PATOGNOMÓNICO	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Brucelosis	Brucella spp. · Quesos de cabra no pasteurizados	Fiebre ondulante + sudor olor paja + sacroileítis	Doxiciclina + Rifampicina por 6 semanas
Leptospirosis (Weil)	Leptospira · Aguas estancadas y orina de rata	Sufusión conjuntival + dolor pantorrillas + ictericia	Penicilina G sódica EV o Ceftriaxona
Fiebre Tifoidea	Salmonella Typhi · Agua y comida contaminada	Disociación esfigmotérmica (Faget) + roséola tífica	Ceftriaxona EV por 7-14 días o Azitromicina

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ENFERMEDAD	EXPOSICIÓN	SIGNO CARDINAL	TRATAMIENTO
Tifoidea, primera semana	Hemocultivos	Widal	No esperar la diarrea

REGLA DE ORO — **Queso de cabra + fiebre ondulante** — Sudor a paja húmeda, sacroileítis

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **69–71** (pág. 17) · solucionario págs. 30–31.

Clase 4.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

4.6 Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)

Rentabilidad media · lesión cutánea característica (escara negra indolora con edema gelatinoso)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.003 Ántrax — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ántrax (Bacillus anthracis)**: bacilo Gram positivo esporulado; transmisión por contacto con ganado o cueros/lanas.
- **Pústula maligna cutánea**: escara necrótica negra central rodeada de vesículas y edema masivo.
- **Signo clave**: la lesión de carbunco cutáneo es TÍPICAMENTE INDOLORA y NO supurativa (sin pus).
- **Carbunco por inhalación**: mediastinitis hemorrágica con ensanchamiento mediastínico en radiografía de tórax.
- **Antibiótico de primera línea**: Ciprofloxacino oral (o Doxiciclina) por **60 días**.
- **Contraindicación formal**: NO realizar desbridamiento quirúrgico de la lesión por riesgo de bacteriemia sistémica.



CARBUNCO CUTÁNEO
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 105

ALGORITMO · ESCARA NEGRA: ¿ES CARBUNCO?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

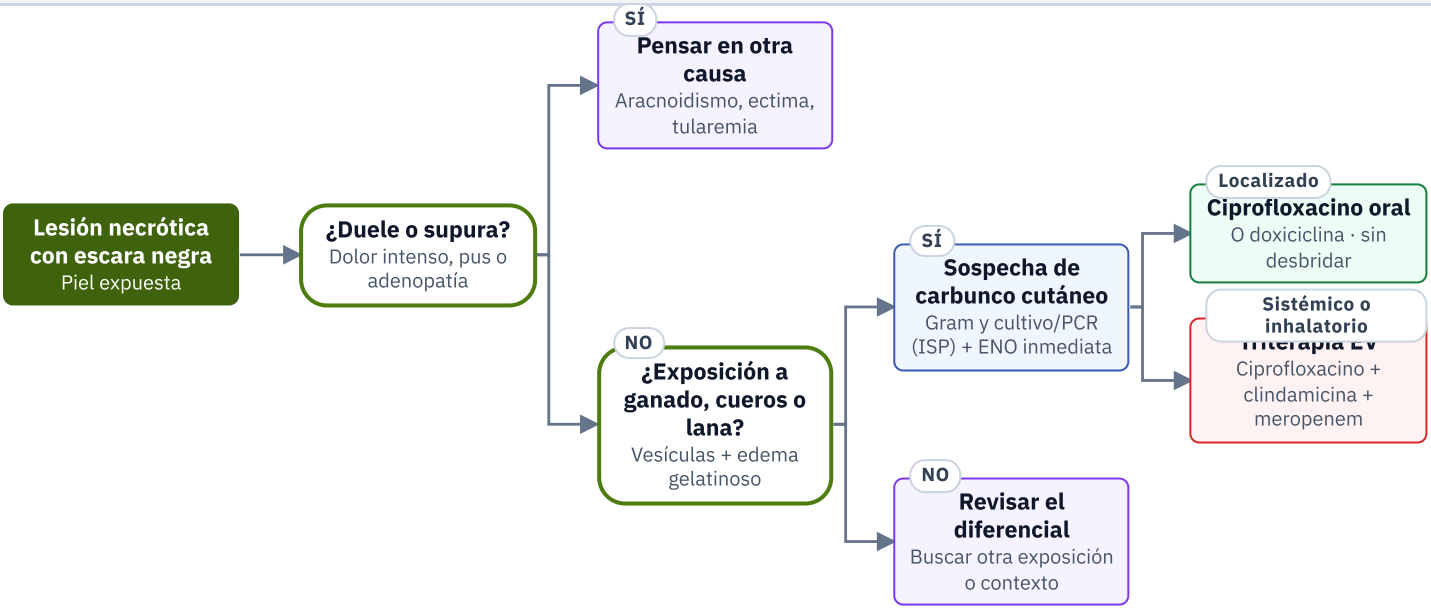


TABLA 4.6 · CARBUNCO CUTÁNEO VS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE ESCARAS NEGRAS

PATOLOGÍA	AGENTE CAUSAL	CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN	DOLOR LOCAL
Ántrax (Carbunco)	Bacillus anthracis	Escara negra seca con vesículas y gran edema	Típicamente INDOLORA y sin pus
Aracnoidismo cutáneo	Loxosceles laeta (araña de rincón)	Placa livedoide violácea con necrosis y flictena	Intensamente dolorosa (quemante)
Ectima gangrenoso	Pseudomonas aeruginosa	Úlcera necrótica con halo eritematoso en neutropénico	Dolor moderado a severo
Tularemia	Francisella tularensis	Úlcera dolorosa asociada a gran adenopatía supurada	Muy dolorosa

REGLA DE ORO **Cueros, lana o ganado** — Escara negra + vesículas + gran edema

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, pregunta **72** (pág. 18) · solucionario pág. 31.

Clase 4.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · diagnóstico diferencial entre celulitis (S. aureus) y erisipela (S. pyogenes)

1.04.1.006 **Celulitis bacteriana** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Erisipela / Celulitis · Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones · Infecciones de piel y partes blandas · Drenaje de abscesos superficiales · Piodermias superficiales y profundas (no linfáticas) · Ántrax · Gram y cultivo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Erisipela**: dermis superficial; Streptococcus pyogenes; placa rojo vivo con BORDES NETOS SOBREELEVADOS.
- **Celulitis**: tejido celular subcutáneo profundo; S. aureus y S. pyogenes; eritema con BORDES DIFUSOS Y MAL DELIMITADOS.
- **Siempre buscar la puerta de entrada**: tinea pedis interdigital (intertrigo micótico) es la causa más común de celulitis de extremidades.
- **Conducta obligatoria**: marcar con lápiz los bordes de la lesión para evaluar progresión o regresión objetiva.
- **Tratamiento oral de elección en Chile**: Cefadroxilo (o Cefalexina o Flucloxacilina) por **7 a 10 días**.
- Si se sospecha SAMR comunitario (abscesos, forúnculos recurrentes, fracaso de betalactámicos): usar Cotrimoxazol o Clindamicina.



ERISIPELA
Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 25

ALGORITMO · INFECCIÓN DE PIEL: BORDE, GRAVEDAD Y ANTIBIÓTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

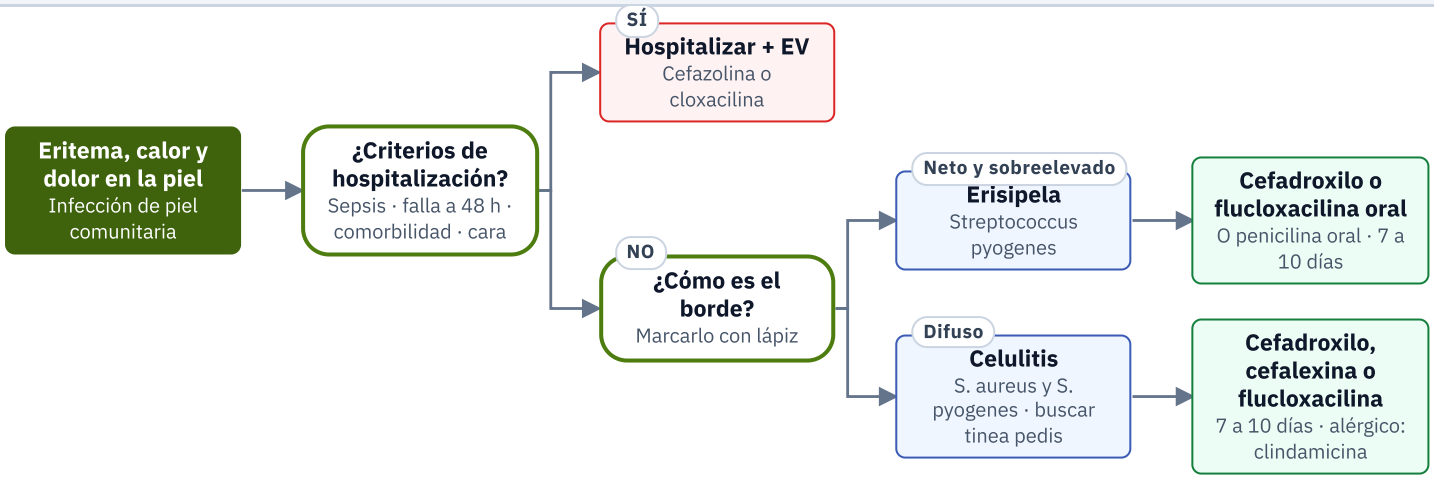


TABLA 5.1 · ERISIPELA VS CELULITIS: CUADRO COMPARATIVO EUNACOM

CARACTERÍSTICA	ERISIPELA	CELULITIS
Profundidad anatómica	Dermis superficial y linfáticos	Dermis profunda y tejido celular subcutáneo
Etiología principal	Streptococcus pyogenes (> 90%)	Staphylococcus aureus y S. pyogenes
Bordes de la lesión	BORDES NETOS, bien delimitados y sobreelevados	BORDES DIFUSOS, irregulares y mal definidos
Inicio de los síntomas	Brusco y agudo, con fiebre alta precoz	Insidioso y progresivo en 24 a 48 horas
Puerta de entrada	A menudo imperceptible o maceración retroauricular	Tinea pedis, úlcera, laceración cutánea visible
Tratamiento oral 1ª línea	Penicilina oral o Cefadroxilo / Flucloxacilina	Cefadroxilo o Cefalexina o Flucloxacilina

REGLA DE ORO **Bordes netos y sobreelevados** — Erisipela: Streptococcus pyogenes

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **76–78** (págs. 18–19) · solucionario págs. 31–32.

Clase 5.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

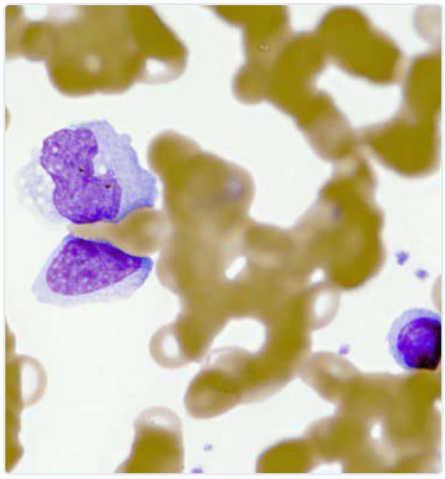
★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.025 Síndrome mononucleósico — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Mononucleosis infecciosa · TORCH · Síndrome febril prolongado · Adenopatías · Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS)

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Mononucleosis por VEB**: faringitis con exudado + adenopatías cervicales posteriores + esplenomegalia.
- **Laboratorio**: leucocitosis con predominio mononuclear y LINFOCITOS ATÍPICOS > **10%** en el frotis.
- **Exantema maculopapular tras recibir Amoxicilina**: inducido por VEB en > **90%**; no es alergia permanente.
- **Recomendación crítica**: PROHIBIDOS deportes de contacto por **3 a 4 semanas** por riesgo de rotura esplénica.
- Causa más frecuente de mononucleosis con anticuerpos heterófilos negativos: Citomegalovirus (CMV).
- **TORCH**: CMV produce calcificaciones periventriculares e hipoacusia; Toxoplasma produce calcificaciones difusas y coriorretinitis.



LINFOCITOS ATÍPICOS
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · SÍNDROME MONONUCLEÓSICO: DE LA FARINGE AL AGENTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

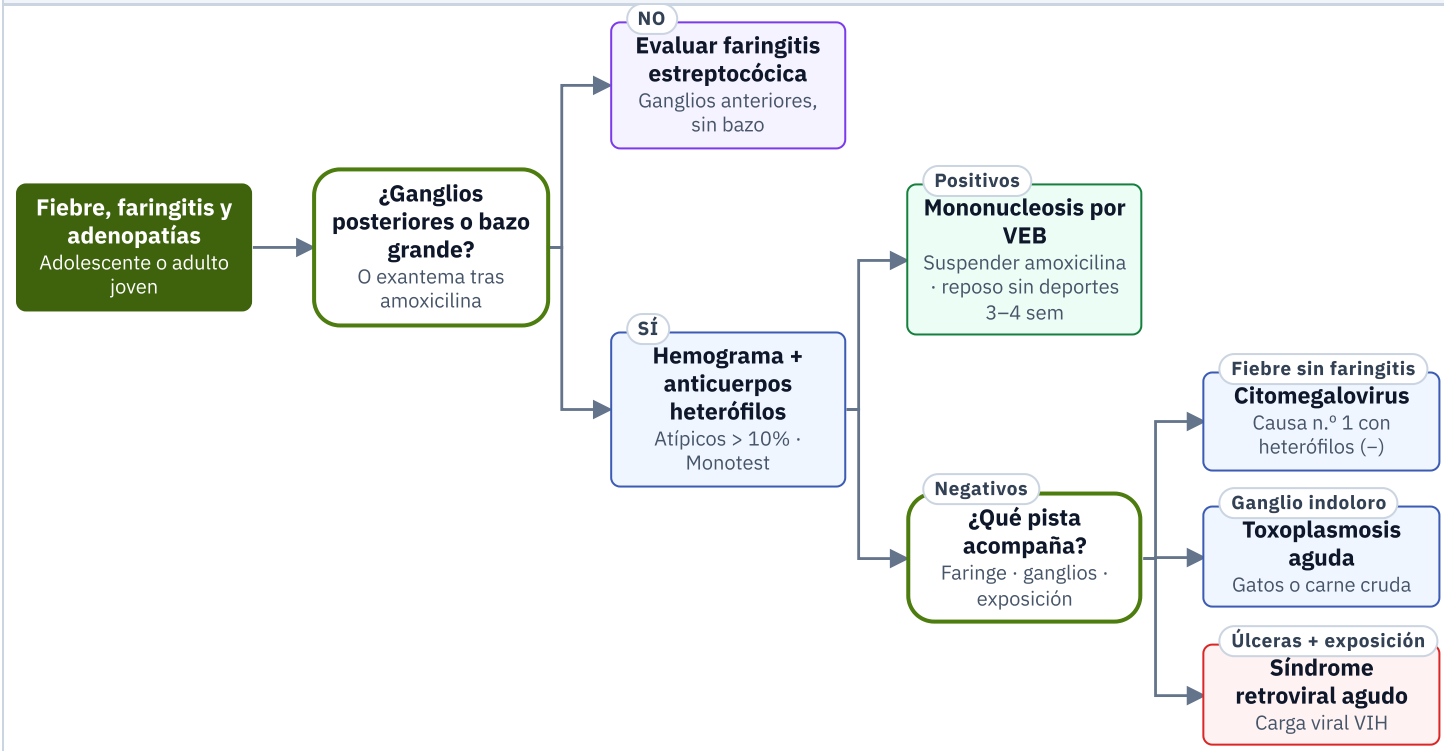


TABLA 5.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DEL SÍNDROME MONONUCLEÓSICO

ETIOLOGÍA	ANTICUERPOS HETERÓFILOS	FARINGITIS Y ADENOPATÍAS	PERLA DISTINTIVA DE EXAMEN
Virus Epstein-Barr (VEB)	POSITIVOS (Paul-Bunnell / Monotest)	Faringitis exudativa + ganglios posteriores	Exantema tras recibir Amoxicilina (95%)
Citomegalovirus (CMV)	NEGATIVOS	Faringitis mínima o ausente	Causa #1 mononucleosis heterófilos (-)
Toxoplasma gondii	NEGATIVOS	Adenopatías cervicales no dolorosas	Exposición a heces de gatos o carnes crudas
VIH primario (SRA)	NEGATIVOS	Faringitis moderada + adenopatías	Úlceras mucosas orales dolorosas + rash

REGLA DE ORO **Faringitis + ganglios posteriores + bazo** — Es VEB, no estreptococo

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **79–81** (pág. 19) · solucionario pág. 32.

Clase 5.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

5.3 Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki

★★★ PRIORIDAD ALTA
38 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.009 Exantemas virales — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Escarlatina · Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Sarampión**: fiebre alta + tos + coriza + conjuntivitis con fotofobia + MANCHAS DE KOPLIK (ENO inmediata).
- **Rubéola**: exantema rosado de **3 días** con ADENOPATÍAS RETROAURICULARES y suboccipitales dolorosas.
- **Escarlatina**: Streptococcus pyogenes; piel áspera "en papel de lija", Facies de Filatov, Líneas de Pastia y lengua en frambuesa; tratar con Amoxicilina **10 días**.
- **Eritema Infeccioso (Parvovirus B19)**: "signo de la bofetada" en mejillas y exantema reticulado "en encaje"; riesgo de crisis aplásica.
- **Enfermedad de Kawasaki**: fiebre **≥ 5 días** + conjuntivitis no exudativa + labios fisurados/lengua frambuesa + edema palmo-plantar + exantema + adenopatía cervical > **1.5 cm**.
- **Tratamiento de Kawasaki**: INMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA (IGEV **2 g**/kg) + ASPIRINA para prevenir aneurismas coronarios.



KAWASAKI: DESCAMACIÓN DE LOS DEDOS
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 103

ALGORITMO · NIÑO CON FIEBRE Y EXANTEMA: BUSCA LA FIRMA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

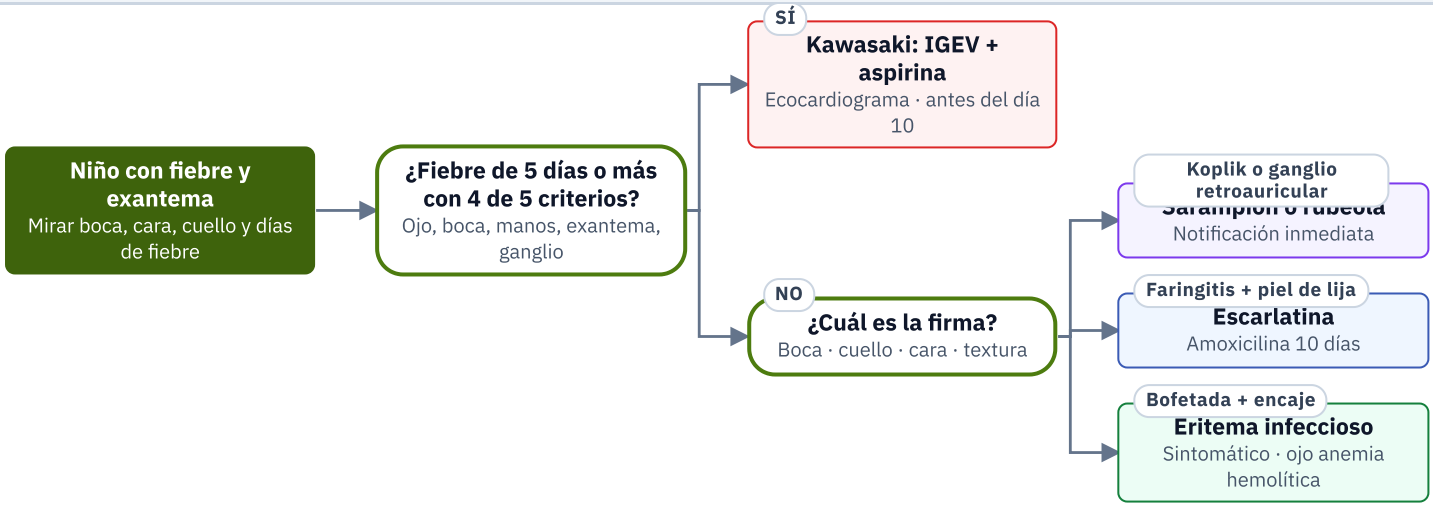


TABLA 5.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS EXANTEMAS FEBRILES CLÁSICOS DE LA INFANCIA

ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL	ENANTEMA / SIGNO PATOGNOMÓNICO	CARACTERÍSTICAS DEL EXANTEMA	TRATAMIENTO EUNACOM
Sarampión	Paramixovirus	Manchas de Koplik (mucosa yugal)	Maculopapular céfalo-caudal confluente	Vitamina A oral + soporte (ENO)
Rubéola	Togavirus	Manchas de Forchheimer + adenopatías retroauriculares	Macular rosado no confluente (3 días)	Sintomático de soporte (ENO)
Escarlatina	Streptococcus pyogenes	Lengua en frambuesa + Líneas de Pastia + Filatov	Micropapular áspero "en papel de lija"	Amoxicilina oral por 10 días completos
Eritema Infeccioso	Parvovirus B19	Signo de la bofetada en mejillas	Patrón reticulado eritematoso "en encaje"	Sintomático (riesgo crisis aplásica)
Enfermedad de Kawasaki	Vasculitis idiopática	Labios fisurados + conjuntivitis seca + lengua frambuesa	Polimorfo + fiebre ≥ 5 días refractaria	Inmunoglobulina EV (2 g/kg) + Aspirina

REGLA DE ORO **Koplik = sarampión** — Ganglio retroauricular = rubéola

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **82–84** (pág. 19) · solucionario págs. 32–33.

Clase 5.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

5.4 Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.011 Enfermedades eruptivas no complicadas (varicela, herpes zoster...) — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Varicela complicada: neumonitis, cerebelitis, encefalitis · Herpes zoster

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Varicela**: lesiones en diferente estadio ("cielo estrellado") con distribución centrípeta; contagiosa hasta que todas son costras.
- **Neumonitis varicelosa**: complicación más grave en ADULTOS (disnea, hipoxemia, infiltrado nodular); requiere ACICLOVIR EV urgente.
- **Ataxia cerebelosa**: complicación neurológica benigna y autolimitada más común en niños.
- **Signo de Hutchinson en Herpes Zóster**: vesícula en la punta de la nariz que avisa riesgo inminente de queratitis oftálmica.
- **Síndrome de Ramsay-Hunt**: parálisis facial periférica + vesículas en el conducto auditivo externo (ganglio geniculado del nervio facial).
- **Tratamiento de Herpes Zóster**: Aciclovir oral **800 mg 5 veces** al día por **7 días** iniciado en las primeras **72 horas**.



VARICELA
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 127

ALGORITMO · VIRUS VARICELA-ZÓSTER: QUIÉN ES Y QUÉ TIENE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

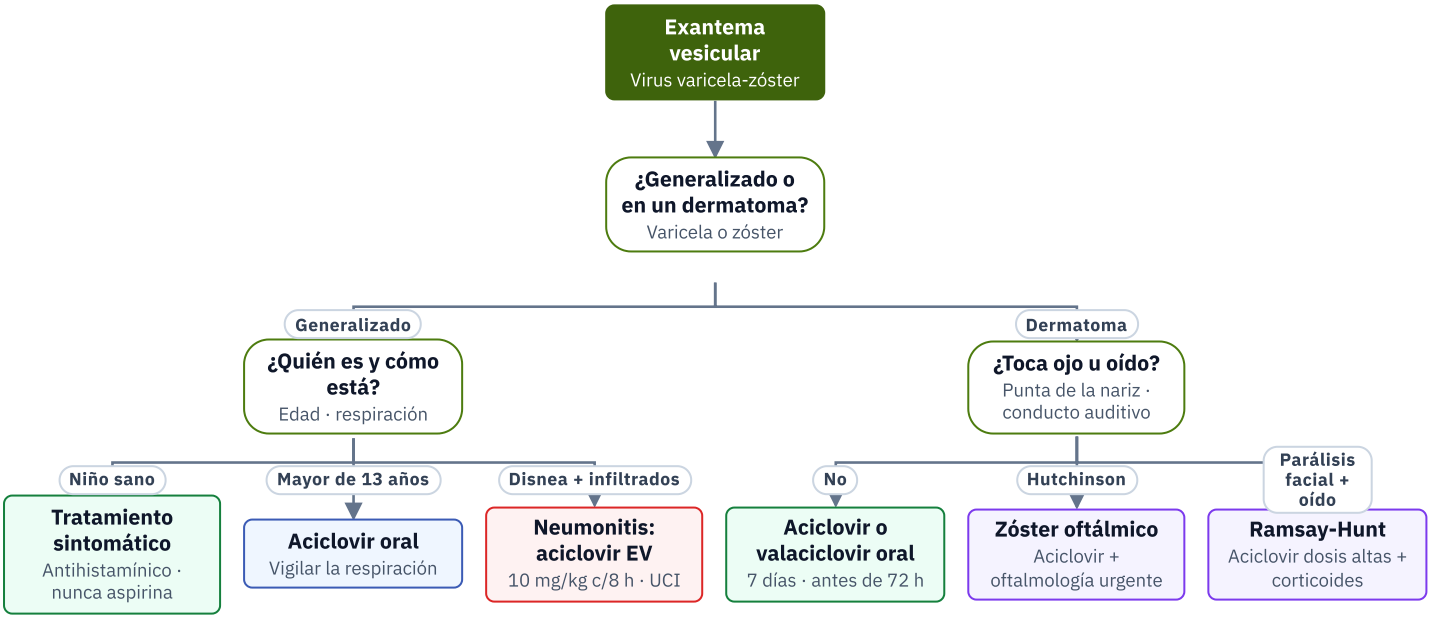


TABLA 5.4 · COMPLICACIONES DE LA INFECCIÓN POR VIRUS VARICELA-ZÓSTER (VVZ)

COMPLICACIÓN	POBLACIÓN VULNERABLE	MANIFESTACIÓN CLÍNICA CARDINAL	CONDUCTA MÉDICA EUNACOM
Neumonitis Varicelosa	Adultos, embarazadas y fumadores	Disnea aguda + infiltrados nodulares bilaterales	Aciclovir EV (10 mg/kg c/8h) + Soporte en UCI
Ataxia Cerebelosa Aguda	Niños preescolares y escolares	Marcha atáxica, dismetría y nistagmo post-varicela	Manejo conservador (autolimitada, buen pronóstico)
Sobreinfección Bacteriana	Niños con prurito intenso y rascado	Fascitis necrotizante o celulitis con pus	Cefazolina / Cloxacilina o Aseo quirúrgico
Herpes Zóster Oftálmico	Adultos mayores (compromiso V1 trigémino)	Signo de Hutchinson (vesícula punta nasal)	Aciclovir oral/EV + Derivación urgente a Oftalmología
Síndrome de Ramsay-Hunt	Adultos con reactivación VII par	Parálisis facial periférica + vesículas en CAE	Aciclovir oral a dosis altas + Corticoides

REGLA DE ORO **Cielo estrellado centrípeto** — Contagia hasta que todo sea costra

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **85–87** (págs. 19–20) · solucionario pág. 33.

Clase 5.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.04.1.020
2.01.1.034
Neutropenia febril

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Micosis invasora (aspergillosis, candidiasis, mucormicosis) · Síndrome febril prolongado

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Definición de Neutropenia Febril**: Fiebre **≥ 38.3** °C (o **≥ 38.0** °C por > **1 h**) + RAN < 500 células/mm³.
- **Emergencia infectológica**: tiempo puerta-antibiótico DEBE ser MENOR A 60 MINUTOS.
- **Antibiótico empírico de elección (alto riesgo)**: Cefepime **2 g** c/**8h** EV (o Piperacilina-Tazobactam **4.5 g** c/**6h** EV).
- **Vancomicina de entrada**: SOLO si hay shock séptico, infección de catéter evidente, mucositis severa o sospecha de SAMR.
- **Bajo riesgo (MASCC ≥ 21)**: opción ambulatoria con Ciprofloxacino + Amoxicilina/Clavulánico oral.
- **Fiebre persistente al 4°-7° día a pesar de antibióticos**: sospechar Aspergilosis o micosis invasora e iniciar Voriconazol o Caspofungina EV.



ECTIMA GANGRENOSO
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · NEUTROPENIA FEBRIL POST-QUIMIOTERAPIA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

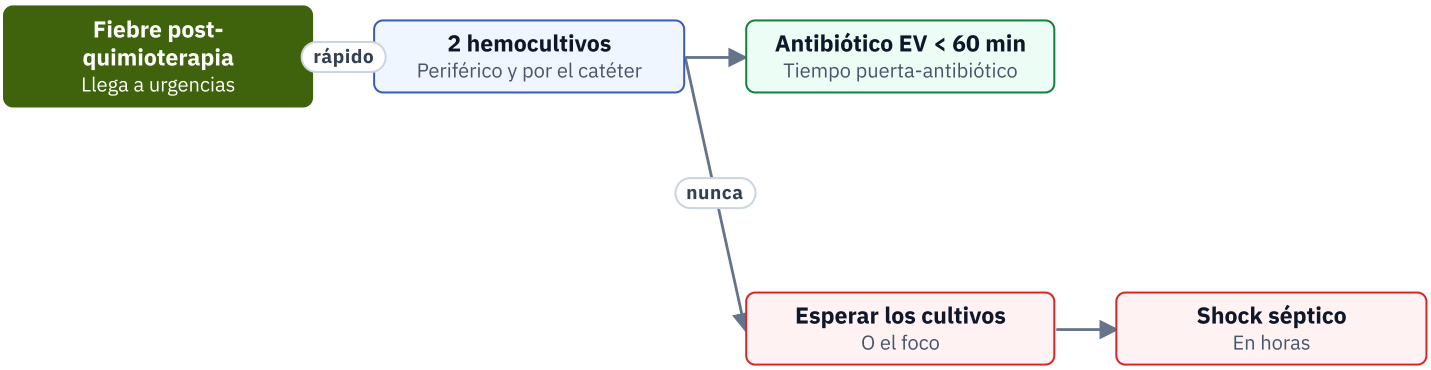


TABLA 5.5 · ESTRATIFICACIÓN Y MANEJO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EUNACOM

CATEGORÍA DE RIESGO	SCORE MASCC	LUGAR DE TRATAMIENTO	ESQUEMA DE ELECCIÓN
Bajo Riesgo	MASCC ≥ 21 puntos	Ambulatorio / Domicilio estricto	Ciprofloxacino oral + Amoxicilina/Clavulánico
Alto Riesgo	MASCC < 21 puntos	Hospitalización en Aislamiento	Cefepime 2 g c/8h EV (o Pip/Tazo) en < 60 min
Alto Riesgo + Shock/CVC	MASCC < 21 + Foco Gram(+)	Unidad de Paciente Crítico (UCI)	Cefepime EV + Vancomicina 15-20 mg/kg EV
Fiebre al 4°–7° día	Refractario a antibióticos	Hospitalizado con TAC de tórax	Voriconazol EV o Equinocandina (Caspofungina)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fiebre post-QT, sin hemograma	Hemograma: calcular el RAN	Partir por imágenes

REGLA DE ORO **Fiebre ≥ 38,3 °C + RAN < 500** — O ≥ 38 °C por más de 1 hora

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, preguntas **88–90** (pág. 20) · solucionario págs. 33–34.

Clase 5.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

5.6 Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

Alta rentabilidad · oseltamivir solo en grupos de riesgo o formas graves, y síndrome inflamatorio multisistémico del niño tras COVID-19

1.04.1.016 Influenza — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19 · SARS Cov 2 COVID 19

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Influenza**: fiebre alta brusca, mialgias, cefalea y tos seca; el diagnóstico en temporada es clínico.
- Oseltamivir **75 mg** cada **12 h** por **5 días** en grupos de riesgo (**≥ 65 años**, embarazo, crónicos, inmunosupresión) y formas graves; en el adulto sano con cuadro leve solo se da tratamiento sintomático.
- No usar aspirina en niños con influenza (síndrome de Reye).
- **COVID-19**: leve, moderada (neumonía con SpO_2 **≥ 94 %**), grave (SpO_2 < **94 %**) y crítica; el diagnóstico es por PCR o test de antígeno.
- Nirmatrelvir/ritonavir en pacientes de riesgo dentro de **5 días**; dexametasona **6 mg**/día solo si requiere oxígeno.
- **MIS-C**: fiebre y compromiso multisistémico **2 a 6 semanas** después de COVID-19, con PCR, ferritina, dímero D y troponina elevados; se deriva a UCI pediátrica para inmunoglobulina y corticoides.



MIS-C: COMPROMISO DIGESTIVO
Nelson 22.ª ed., Fig. 311.4

ALGORITMO · SÍNDROME RESPIRATORIO FEBRIL: INFLUENZA Y COVID-19

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



TABLA 5.6 · INFLUENZA VERSUS COVID-19: DIFERENCIAS PRÁCTICAS

ASPECTO	INFLUENZA	COVID-19	CONDUCTA
Inicio y síntomas	Brusco; fiebre alta, mialgias, cefalea intensos	Variable; anosmia/ageusia, disnea, cuadro más prolongado	Confirmar con PCR o antígeno
Antiviral	Oseltamivir 75 mg c/12 h x 5 días	Nirmatrelvir/ritonavir x 5 días o remdesivir x 3 días	Solo riesgo o gravedad (influenza: no esperar confirmación si es grave)
Corticoides	No recomendados de rutina	Dexametasona 6 mg/día si requiere oxígeno	Hospitalizar si SpO_2 < 94 %
Complicación pediátrica	Neumonía, miocarditis, Reye con AAS	MIS-C 2 a 6 semanas después	Derivar a UCI pediátrica
Vacuna	Anual (inactivada)	Esquema y refuerzos según PNI	Priorizar grupos de riesgo

REGLA DE ORO **Fiebre brusca, mialgias, tos seca** — Diagnóstico clínico en temporada

PRACTICA **Libro Gordo Infectología**, pregunta **74** (pág. 18) · solucionario pág. 31.

Clase 5.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 25 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC	
1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)	pág. 3
FR **≥ 22 rpm** — Taquipnea	CORTE
PAS **≤ 100 mmHg** — Presión sistólica baja	CORTE
1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral	pág. 4
PMN + glucosa < 0,4 — Bacteriana	CORTE
Dexametasona **10 mg** c/**6 h** EV — Por **4 días**	DOSIS
1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	pág. 5
Ceftriaxona + metronidazol — Cirugía si mide > **2,5 cm**	CORTE
Ceftriaxona **2 g** c/**12 h** EV — Estreptococos	DOSIS
PCR para VHS-1 en LCR — Sensibilidad y especificidad > **95 %**	CORTE
1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	pág. 6
Marcar el borde del eritema — Reevaluar en **12 a 24 horas**	TIEMPO
Adenoflegmón: ya fluctúa — Antibiótico **7–10 días** y drenaje	TIEMPO
BLOQUE 02 · SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS	
2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	pág. 7
Embarazada: ceftriaxona **250 mg** IM — Dosis única	DOSIS
Azitromicina por **5 días** — Contactos sintomáticos, < 1 año, embarazadas	CORTE
2.2 Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	pág. 8
IGH-T: herida sucia + < 3 dosis — O esquema desconocido	DOSIS
Influenza anual — Embarazadas, **≥ 65, crónicos**, personal de salud	CORTE
2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	pág. 9
Hemocultivos pareados — CVC positivo > **2 h** antes que el periférico	CORTE
Cursos cortos — La mayoría, **5 a 7 días**	TIEMPO
Reevaluar a las **48–72 h** — Descalar y pasar a vía oral	TIEMPO
2.4 Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	pág. 10
< **6 h**, vómitos sin fiebre — Toxina preformada: aureus o cereus	CORTE
Doxiciclina **300 mg** dosis única — Acorta la duración	DOSIS
BLOQUE 03 · INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS	
3.1 Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)	pág. 11
CD4 < 200/mm³ — Aunque esté asintomático	CORTE
I = I — Carga viral < 50 por más de **6 meses**	CORTE
3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	pág. 12
Presión de apertura > **30 cm** H2O — Muy elevada	CORTE
LDH muy elevada — Más de **400–500 UI**/L	DOSIS
Cotrimoxazol dosis altas, **21 días** — Corticoides si PaO2 < 70 o A-a **≥ 35**	DOSIS
3.3 Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	pág. 13
LCR: glucosa muy baja — Proteínas > **200–500 mg/dL** · linfocitos	DOSIS
Derrame linfocítico + ADA > 40 — Pleuritis tuberculosa	CORTE
Exudado unilateral linfocítico — Linfocitos más de **80%**	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas	pág. 14
Sífilis precoz (< 1 año): Penicilina Benzatina 2.4 MU IM en DOSIS ÚNICA.	DOSIS
VDRL: actividad y respuesta — Curación: caída de **4 veces**	CORTE
3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH	pág. 15
Ciprofloxacino: no — Resistencia del gonococo en Chile > **50 %**	CORTE
Ceftriaxona **500 mg** IM — Dosis única · cubre el gonococo	DOSIS
PAP cada **3 años** — Entre los 25 y **64 años**	CORTE
BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES	
4.1 Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)	pág. 16
Hemoconcentración — Hematocrito > **45–50 %**	CORTE
Trombocitopenia marcada — Plaquetas < 100.000/mm³	CORTE
4.2 Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica	pág. 17
Nifurtimox **8–10 mg/kg**/día — Por **60 días**	DOSIS
Benznidazol **5–7 mg/kg**/día — Por **60 días**	DOSIS
Hipertrófica: septo **≥ 15 mm** — Soplo que aumenta con Valsalva; muerte súbita	CORTE
4.3 Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	pág. 18
Antígeno NS1 — En los primeros **5 días**	TIEMPO
Embarazo — Y lactantes menores de **9 meses**	TIEMPO
4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	pág. 19
Fiebre alta persistente — **39–40 °C**	CORTE
Cirugía + albendazol — Antes y después · **10–15 mg/kg**/día	DOSIS
Albendazol **400 mg** c/**12 h** — Por **10 a 14 días**, o mebendazol	DOSIS
4.5 Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	pág. 20
Ceftriaxona **2 g**/día EV — Por **7 a 14 días**	DOSIS
Hemocultivos: semana 1 — Positivos en **80–90%**	TIEMPO
4.6 Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)	pág. 21
Alternativa: doxiciclina — **100 mg** c/**12 h** oral	DOSIS
Ciprofloxacino **500 mg** c/**12 h** oral — O levofloxacino, por **60 días**	DOSIS
BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO	
5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis	pág. 22
Clindamicina **300 mg** c/**8 h** — Alergia a betalactámicos	DOSIS
Cefadroxilo **500 mg** c/**12 h** — O cefalexina **500 mg** c/**6 h**	DOSIS
O flucloxacilina **500 mg** c/**8 h** — Cubren S. aureus y S. pyogenes	DOSIS
5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH	pág. 23
Hemograma — Linfocitosis con atípicos > **10%**	CORTE
Esplenomegalia — En **50 a 60%**	CORTE
Neutrofilia con desviación a izquierda — Bacteriana · > 15.000/mm³	CORTE
5.3 Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki	pág. 24
Adenopatía cervical unilateral — **≥ 1,5 cm**, no purulenta	CORTE
Amoxicilina **50 mg/kg**/día — **10 días** completos	DOSIS
Preceden al exantema — En **24 a 48 horas**	TIEMPO
5.4 Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster	pág. 25
Aciclovir **800 mg 5 veces** al día — Por **7 días**	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
5.6 Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño) (cont.)	pág. 27
O valaciclovir **1 g** c/**8 h** — Idealmente antes de **72 horas**	DOSIS
5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	pág. 26
Un registro **≥ 38,3** °C — Basta una sola toma	CORTE
O **≥ 38,0** °C por más de **1 hora** — Fiebre sostenida	CORTE
5.6 Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)	pág. 27
Dexametasona solo con oxígeno — Hospitalizar si SpO_2 < **94%**	META
Niños: dosis por peso — **≤ 15 kg 30 mg**; hasta > **40 kg 75 mg**	DOSIS

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)		pág. 3
Los primeros 60 minutos · Tratar	**Antibióticos EV de amplio espectro**	Dosis plenas, según foco probable
1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral		pág. 4
Esquema estándar	**Ceftriaxona 2 g c/12 h EV**	Cubre neumococo y meningococo
Esquema estándar	**+ Vancomicina 15–20 mg/kg c/12 h EV**	Por neumococo resistente
Meningococcemia · Conducta inmediata	**Hemocultivos y ceftriaxona 2 g EV**	Volumen, UCI, corticoide si shock refractario
1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral		pág. 5
Empírico	**+ Metronidazol 500 mg c/8 h EV**	Anaerobios del foco ótico o sinusal
Empírico	**+ Vancomicina si trauma o cirugía**	Antecedente de TEC o neurocirugía
Meningitis bacteriana según la edad · EV de inmediato	**Menor de 1 mes: ampicilina + cefotaxima**	Mayor de **1 mes**: ceftriaxona + vancomicina
Meningitis bacteriana según la edad · EV de inmediato	**Dexametasona 0,15 mg/kg c/6 h**	Solo mayores de **1 mes** · **2 a 4 días**
1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig		pág. 6
Fascitis necrotizante	**Vancomicina**	Se suma al esquema empírico
Fascitis necrotizante	**Clindamicina**	Bloquea la síntesis de toxinas
2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes		pág. 7
Meningococo y coqueluche · Meningococo	**O ciprofloxacino 500 mg dosis única**	
Meningococo y coqueluche · Meningococo	**Embarazada: ceftriaxona 250 mg IM**	Dosis única
2.2 Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico		pág. 8
Tétanos establecido	**Metronidazol EV o penicilina**	Contra la bacteria
Mordedura · 3 a 5 días	**Amoxicilina-ácido clavulánico**	Alérgicos: doxiciclina o clindamicina + cipro
2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento		pág. 9
Tratamiento empírico	**Vancomicina EV**	Cubre SAMR y coagulasa negativo
Tratamiento empírico · + BGN si séptico o neutropénico	**Cefepime, piperacilina-tazobactam o amikacina**	
2.4 Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera		pág. 10
Moderado a severo	**Doxiciclina 300 mg dosis única**	Acorta la duración
Moderado a severo	**Niños y embarazadas: azitromicina**	Dosis única
3.1 Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)		pág. 11
Test and Treat · Esquema de primera línea	**Tenofovir + lamivudina + dolutegravir**	TDF / 3TC / DTG co-formulados
Test and Treat · Esquema de primera línea	**Dolutegravir: inhibidor de integrasa**	Alta barrera genética, supresión rápida
3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA		pág. 12
Por fases	**Luego fluconazol oral**	Consolidación y mantención prolongada
En el VIH	**Cotrimoxazol con CD4 bajo 200**	Pneumocystis y toxoplasma (CD4 bajo 100)
En el VIH	**Vacunas inactivadas**	Evitar vivas con CD4 bajo 200
3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas		pág. 14
Sífilis congénita · Neonatología	**O tratada con otro antibiótico**	
Sífilis congénita · Neonatología	**Penicilina G sódica EV por 10 días**	Prevención: tratar a la gestante **30 días** antes

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH		pág. 15
Toda uretritis · Esquema de elección	**Ceftriaxona 500 mg IM**	Dosis única · cubre el gonococo
Toda uretritis · Esquema de elección	**+ Doxiciclina 100 mg c/12 h × 7 días**	O azitromicina **1 g** oral dosis única · cubre la clamidia
Se trata el síndrome, no el germen · Prevenir	**Vacunas VPH y hepatitis B · tamizaje**	PrEP en alto riesgo · pareja: abstinencia **7 días**
4.2 Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica		pág. 17
Antiparasitarios · 60 días	**Benznidazol 5–7 mg/kg/día**	Por **60 días**
Miocardiopatías · Médico general	**IECA o ARA-II, betabloqueador, espironolactona**	
4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis		pág. 19
La tríada y la eosinofilia · Albendazol	**Albendazol 400 mg c/12 h**	Por **10 a 14 días**, o mebendazol
La tríada y la eosinofilia · Albendazol	**Corticoides si es severa**	Miocarditis o toxicidad sistémica
Hidatidosis pulmonar · Derivar	**Cirugía + albendazol**	Antes y después · **10–15 mg/kg**/día
4.5 Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea		pág. 20
Confirmar y tratar sin recaídas · Biterapia obligatoria	**Doxiciclina + rifampicina**	Doxi **100 mg** c/**12 h** + rifampicina **600–900 mg**/día
Confirmar y tratar sin recaídas · Biterapia obligatoria	**Alternativa: doxiciclina + gentamicina 2 semanas iniciales**	
Confirmar y tratar según la gravedad · Según gravedad	**Forma leve: doxiciclina oral**	Manejo ambulatorio
Confirmar y tratar según la gravedad · Según gravedad	**Weil: penicilina G sódica EV**	O ceftriaxona endovenosa
4.6 Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)		pág. 21
	Ciprofloxacino 500 mg c/12 h oral	O levofloxacino, por **60 días**
	Alternativa: doxiciclina	**100 mg** c/**12 h** oral
Sistémico o inhalatorio	**Ciprofloxacino + clindamicina + meropenem EV**	
5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis		pág. 22
Primera línea oral	**Cefadroxilo 500 mg c/12 h**	O cefalexina **500 mg** c/**6 h**
Primera línea oral	**O flucloxacilina 500 mg c/8 h**	Cubren S. aureus y S. pyogenes
Drenar un absceso	**Antibiótico si celulitis > 5 cm, SIRS o riesgo**	Cara, manos, genitales, diabetes
5.3 Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki		pág. 24
Escarlatina · Prevenir fiebre reumática	**Amoxicilina 50 mg/kg/día**	**10 días** completos
Schönlein-Henoch · Clínico	**Corticoide si el dolor abdominal es intenso**	
5.4 Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster		pág. 25
Primeras 72 horas	**Aciclovir 800 mg 5 veces al día**	Por **7 días**
Primeras 72 horas	**O valaciclovir 1 g c/8 h**	Idealmente antes de **72 horas**
5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco		pág. 26
Alto o bajo riesgo · La trampa	**Ceftriaxona no cubre Pseudomonas**	No es el antibiótico de elección
Dosis	**Vancomicina 15–20 mg/kg EV**	Junto al cefepime, en UCI
5.6 Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)		pág. 27
Oseltamivir · Adulto sano con cuadro leve	**Sintomático; oseltamivir opcional**	
Leve a moderado · Sintomático y signos de alarma	**Paracetamol, hidratación, reposo y aislamiento**	

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
5.6 Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño) (cont.)		pág. 27
Leve a moderado	**Con riesgo de progresión: nirmatrelvir/ritonavir**	300/**100 mg** cada **12 h** por **5 días**, en los primeros **5 días**
Leve a moderado	**Antibióticos solo si hay sobreinfección**	Nunca de rutina

GES de Infectología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo Integral del Paciente Crítico en Cuidados Intensivos**

Tema **1.1** · Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)
`1.04.2.007` · `4.01.2.029` · `2.01.2.023`
pág. **3**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Infecciones del Sistema Nervioso Central en Adultos y Pediatría**

Tema **1.2** · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral
`1.04.2.006` · `1.04.4.006` · `1.04.5.002`
pág. **4**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Infecciones del Sistema Nervioso Central**

Tema **1.3** · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral
`1.04.2.002` · `1.10.2.014` · `1.04.2.001`
pág. **5**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Infecciones Graves de Cabeza, Cuello y Partes Blandas**

Tema **1.4** · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig
`1.04.2.005` · `1.04.2.004` · `1.04.1.001`
pág. **6**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Prevención de la Transmisión Vertical de VIH y Sífilis · Programa Nacional TBC MINSAL**

Tema **2.1** · Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes
`1.04.3.009` · `1.04.3.010` · `1.04.3.001`
pág. **7**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Prevención y Profilaxis Post-Exposición Rabia y Tétanos**

Tema **2.2** · Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico
`1.04.2.009` · `1.04.3.008` · `1.04.3.002`
pág. **8**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 18): Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA)**

Tema **3.1** · Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)
`1.04.1.014` · `3.01.1.031` · `2.01.1.012`
pág. **11**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 18): Tratamiento de Infecciones Oportunistas en VIH**

Tema **3.2** · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA
`1.04.1.014` · `1.05.1.029` · `1.04.3.006`
pág. **12**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 35): Prevención y Diagnóstico de la Transmisión Vertical de Sífilis**

Tema **3.4** · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas
`1.04.1.023` · `1.04.1.010` · `1.04.4.016`
pág. **14**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer Cervicouterino (Tamizaje VPH / PAP)**

Tema **3.5** · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH
`1.04.1.010` · `4.01.1.058` · `3.01.3.010`
pág. **15**

GES **Garantía Explícita en Salud: Tamizaje Prenatal Sífilis y Chagas · Red Nacional de Salud**

Tema **5.2** · Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH
`1.04.1.025` · `2.01.1.016` · `2.01.1.127`
pág. **23**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de Neutropenia Febril en Pacientes con Cáncer**

Tema **5.5** · Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco
`1.04.1.020` · `1.04.1.019` · `2.01.1.034`
pág. **26**

Fármacos de primera línea · continuación

Sin garantía GES específica (13 temas): 2.3 · 2.4 · 3.3 · 4.1 · 4.2 · 4.3 · 4.4 · 4.5 · 4.6 · 5.1 · 5.3 · 5.4 · 5.6. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **5.3** Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki 24
- ★★★ **5.1** Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis 22
- ★★★ **3.5** Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH 15
- ★★★ **5.2** Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH 23
- ★★★ **3.2** Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA 12

Practica: Libro Gordo Infectología, preguntas 37, 41–43, 50–54, 76–84.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **3.1** Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES) 11
- ★★★ **3.3** Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR 13
- ★★★ **4.2** Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica 17
- ★★★ **2.3** IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento 9

Practica: Libro Gordo Infectología, preguntas 19–22, 30–32, 38–40, 44–46, 59–60.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **1.3** Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral 5
- ★★☆ **4.4** Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis 19
- ★★☆ **1.2** Meningitis Aguda Bacteriana y Viral 4
- ★★☆ **5.5** Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco 26

Practica: Libro Gordo Infectología, preguntas 6–13, 55, 65–68, 88–90.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **5.4** Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster 25
- ★★☆ **3.4** Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas 14
- ★★☆ **4.5** Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea 20
- ★★☆ **5.6** Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño) 27

Practica: Libro Gordo Infectología, preguntas 47–49, 69–71, 74, 85–87.

DÍA 5

4 temas · ★

- ★☆☆ **2.1** Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes 7
- ★☆☆ **2.4** Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera 10
- ★☆☆ **1.4** Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig 6
- ★☆☆ **1.1** Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora) 3

Practica: Libro Gordo Infectología, preguntas 4–5, 14–18, 23–26, 33–36, 73.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **4.1** Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH) 16
- ★☆☆ **4.3** Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla 18
- ★☆☆ **2.2** Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico 8
- ★☆☆ **4.6** Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio) 21

Practica: Libro Gordo Infectología, preguntas 27–29, 56–58, 61–64, 72.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 28
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 2.3 · 3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.5 · 4.2 · 5.1 · 5.2 · 5.3
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Infectología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 9 temas

38 5.3. Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki 24
20 5.1. Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis 22
18 3.5. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH GES 15
18 5.2. Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH GES 23
11 3.2. Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA GES 12
10 3.1. Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES) GES 11
10 3.3. Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR 13
10 4.2. Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica 17
8 2.3. IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento 9

★★ Prioridad media · 8 temas

7 1.3. Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral GES 5
7 4.4. Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis 19
6 1.2. Meningitis Aguda Bacteriana y Viral GES 4
6 5.5. Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco GES 26
5 5.4. Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster 25
4 3.4. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas GES 14
4 4.5. Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea 20
4 5.6. Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño) 27

★ Prioridad baja · 8 temas

3 2.1. Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes GES 7
3 2.4. Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera 10
2 1.4. Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig GES 6
1 1.1. Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora) GES 3
1 4.1. Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH) 16
1 4.3. Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla 18
0 2.2. Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico GES 8
0 4.6. Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio) 21